

脉理求真

清·黄宫绣 著

4.1
5



脉理求真

清·黄 宫 繡 著

人 民 卫 生 出 版 社

出版者的话

中国医药学是一个伟大的宝库。为了继承发扬这份文化遗产，过去我社影印、排印出版了一批历代中医典籍。由于当时发行数量较少，以后又很少重印，许多书在社会上早已很难看到了。

随着我国卫生事业的发展，临床、教学、科研人员要求阅读历代医学原著的呼声越来越高。为了满足国内外广大读者的需要，遵照卫生部关于有计划地整理出版中医药古代书籍的指示精神，我社特选择历代有代表性的中医名著，进行校勘、句读，出版发行。

应该指出，历代中医古书中，有些现代科学尚不能解释的问题，或因受历史条件的限制夹杂了一些不当的内容，希望读者以辩证唯物主义的观点，正确对待，认真研究它的理论和经验，用科学方法进行整理和提高，发掘宝藏，吸取精华，推动中医这门科学的进一步发展。

人民卫生出版社

目 录

卷 一

新著脉法心要	1
部位	1
胃脉	4
浮脉	5
沉脉	5
数脉	6
迟脉	7
長脉	8
短脉	8
大脉	9
小脉	9
洪脉	10
微脉	11
实脉	11
虛脉	12
紧脉	12
緩脉	13
芤脉	14
濡脉	14
弦脉	15
弱脉	16
滑脉	16
瀉脉	17
动脉	17
伏脉	18

促脉	19
結脉	19
革脉	20
牢脉	20
疾脉	20
細脉	21
代脉	22
散脉	22
奇經八脉	23
冲陽等脉	24
五臟死脉	24
对待	25
比类	25
綱目	26
以脉主病	27
脉真从脉	27
症真从症	28
脉見有力無力难憑	28
脉兼望聞問同察	29
脉以独見为真	30

卷 二

新增四言脉要	33
--------------	----

卷 三

汪昂訂十二經脉歌	51
汪昂奇經脉歌	59
新增脉要簡易便知	61

卷 一

新著脉法心要

繙按：脉为血脉，一身筋骨，皆于是宗；一身疾痛，皆于是征。考諸先哲遺論，固多精义独标，旨归若揭，以为后世章程。然有牽引时令，巧借生死刻应，敷衍滿幅；与夫就脉就症，分断考求，毫無变换，似非临症要語。是篇綴精聚华，僭为鄙句，既以去乎膚廓，复更化裁尽变，推行尽通，洵医中之活潑，脉法之喫紧至要处也。用是另为篇帙，聊贅数言，以弁其首。又按，篇中所論脉要，前半止就脉象部位，閑閑叙入，各就要处指明。至后始將診脉大要，层层剝进，不令診法稍有遺义，如中庸所論極致之功，反求其本，以至声色俱泯而后已。讀者慎毋取其脉象部位，而置后幅变活要义于不申也。晦菴朱子曰：古人察脉非一道，今世惟守寸关尺之法，所謂关者多不明。独俗傳脉訣，詞最鄙淺，非叔和本書，乃能直指高骨为关。然世之高医，以其書賈，遂委去而羞言之。云間錢溥曰：晋太医令王叔和著脉經，其言可守而不可变。及托叔和脉訣行，而医經之理遂微。盖叔和为世所信重，故假其名而得行耳。然医道之日淺，未必不由此而誤之也。張璠診宗三昧云：王氏脉經，全氏太素，多拾經語，溷廁杂毒于中。偶一展卷，不無金屑入眼之憾。至于紫虛四診、丹溪指掌、嬰宁樞要、瀕湖脉学、土材正眼等書，靡不称誉于时，要皆刻舟求劍，按圖索驥之說，而非診要切語矣。

部位 持脉之道，貴乎活潑。脉，按內經謂之經隧，后人謂之經脉，林之翰指为肌肉空松之处，包藏营气，而为晝夜运行不息之道路，所以載脉者也。若拘泥不通，病难以測。姑以部位論之：如左寸心部也，其候在心与膻中；右寸肺部也，其候在肺与胸中；左关肝部也，其候在肝胆，右关脾部

也，其候在脾胃；左尺腎部也，其候在腎部膀胱小腸；右尺三焦部也，其候在腎與三焦命門大腸；寸上為魚際，尺下為尺澤；故察兩寸而知頭面咽喉口齒頭痛肩背之疾，察關而知脇肋腹背之疾，察尺而知腰腹陰道脚膝之疾，此皆就上以候上，中以候中，下以候下之謂也。內經曰：尺內兩傍，則季肋也。尺外以候腎，尺里以候腹中。附上，左外以候肝，內以候膈；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候胸，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛中事也。張景岳曰：小腸大腸，皆下部之腑，自當应于兩尺。而二腸又連于胃，氣本一貫，故內經亦不言其定處，而但曰大腸小腸，皆屬于胃，是又于胃氣中察二腸之氣。自叔和以心与小腸，合于左寸，肺与大腸，合于右寸。其謬甚矣。竊按：經絡經絡貫接，則大小腸自當診于兩寸；論脈上下位置，則大小腸又當診于兩尺。而烏程林之翰專推王氏脈經，本以經絡貫注當診于寸之說，著為管窺附余，其理雖屬不易，但將諸家大小腸診尺之說，借為詆毀，以表獨得，不惟理與內經相違，且更生其上下倒置之弊矣。然五臟六腑，其脈靡不悉統于肺。肺雖五臟之一，而實為氣之大会，故于右關之前一分為氣口，候之以占終身焉。吳草廬曰：脈行始于肺，終于肝，而復會于肺。肺為氣所出之門戶，故名曰氣口，而為脈之大会，以占終身。且諸氣不能自致于肺，又必借胃水谷以為輸將，以為灌溉；故胃又為先天之氣化，後天之本源，而為諸氣之統司焉。每見陰虛血耗之人，日服六味四物而不得陰長之力，其故實基此耳。豈盡于六部是求，而不归于氣口胃氣是診乎。提出胃氣為診脈之要。胃氣者，谷氣也。谷氣減少，即為胃氣將絕，血何從生。

今人好用四物，而不顧瞻谷食多寡，以阻生血之源者，比比皆是。經脉別論云：食氣入胃，經氣歸于肺，肺朝百脉，氣歸于權衡，權衡以平，氣口成寸，以決死生。營衛生會云：人食氣于谷，谷入于胃，以傳于肺，五臟六腑，皆以受氣。其清者為營，濁者為衛，營行脉中，衛行脉外。命門相火，雖寄在右，腎水雖寄在左；然腎同居七節，一陰一陽，精氣皆主，閉蟄封藏，令各得司，豈腎獨歸于左，而不予右可診乎。至于三部并取而為九候，則在表在里在中，又各見于六部之浮中沉。是蓋外以候外，里以候里，中以候中。豈盡寸陽尺陰，所能統其表里者乎。頭痛在上，本應寸見。而少陽陽明頭痛，則又在于兩关；邪傳足少陽胆經，頭痛在左关；邪傳足陽明胃經，頭痛在右关。太陽（膀胱）頭痛，則又在于左尺。是痛在于上者，又不可以上拘矣。淋遺在下，本應尺求。而氣虛不攝。則病偏在右寸；神衰不固。則病偏在左寸。是淋遺在下者，又不可以下拘矣。中氣虛而吐瀉作，則吐似在于寸，瀉亦應在于尺；如何偏于关求以固脾胃。二氣混而中道塞，則治應在兩关；如何偏宜升清以从陽，苦降以求陰。則病在于上中下者，又不可盡以所見之部拘之矣。部位難拘如此。繙按：六部之浮，皆可以候心肺；六部之沉，皆可以候兩腎；六部之中，皆可以候肝脾。且兩腎之脉，有時偏以浮見尺寸見；心肺之脉，有時偏以沉見尺見；肝脾之脉，有時偏以浮沉見尺寸見。王宗正曰：診脉當从心肺俱浮，肝腎俱沉，脾在中州之說。若王叔和獨守寸关尺部位以測病，甚非。

胃脉 再以脉象論之，如肝脉宜弦，弦屬本臟。然必和滑而緩，則弦乃生；若使中外堅搏強急之極，則弦其必死矣。心脉宜洪，洪屬本臟。然必虛滑流利，則洪乃生；若使洪大至極，甚至四倍以上，則洪其必死矣。脾脉宜緩，緩屬本臟。然必軟滑不緊，則緩乃平；若使緩而瀯滯，及或細軟無力，与乍數乍疏，則緩其必死矣。肺脉宜浮，浮即肺候。然必脉弱而滑，是為正脉；若使虛如鷄羽。加以关尺細數，喘嗽失血，則浮其見斃矣。腎脉沉實，實即腎候。然必沉濡而滑，方為正脉；若使弦細而勁，如循刀刃，按之搏指，則實其莫救矣。說臟脉只好如斯，不可搬演過甚，以致要處反略。景岳曰：凡肝脉但弦，腎脉但石，名為真臟者，以無胃氣也。蓋元氣之來，脉來和緩；邪氣之至，脉來勁急。必得脉如阿阿，軟若陽春柳，方為脾氣胃脉氣象耳。胃气脉象，不過如是。更須察其谷食是否減少，是否消化。若谷食日少，速當于此審治，不得于此混進濡滯等藥。夫胃氣中和，旺于四季。其在于春，脉宜微弦而和，說时令脉，只好如斯，多則便涉支蔓矣。獨怪世人專以时令生尅，強肥滿腹，其脉如何形象，如何變換，如何真假，全不体会。夏宜微洪而和，秋宜微浮而和，冬宜微實而和。使于四季，而不見有和緩之氣，則為真臟脉見，而為不治之症矣。胃脉宜審如此，故六脉皆可察胃有無，豈必在于右关之胃，而始定其吉凶哉。扫尽时令生尅膚辭，独标和緩、微弦、

微洪等語，以名胃脉，眞得診家要訣。繙按，四診抉微、脉訣归正諸書，所論時令脉体，多以生死刻應敷衍，理虽不易，然非臨症切脉確論。

浮脉 其有所云浮者，下指即显浮象，举之汎汎而流利，按之稍減而不空。凡芤大洪革，虛濡微散，皆屬浮类。不似虛脉按之不振，芤脉按之減小，濡脉綿軟無力也。語出張璐。又瀕湖体狀詩曰：浮脉惟从肉上行，如循榆莢似毛輕；三秋得令知無恙，久病逢之却可惊。又相类詩曰：浮如木在水中浮，浮大中空乃是芤；拍拍而浮是洪脉，來時虽盛去悠悠。浮脉輕平如捻葱，虛來迟大豁然空；浮而柔細方為濡，散似楊花無定蹤。浮為虛損不足。凡風暑脹滿不食，表熱喘急等症，皆有上浮之义。若使浮而兼大，則為傷風；浮而兼緊，則為傷寒；張璐曰，外感暴得，多見人迎浮盛。浮而兼滑，則為宿食；浮而兼緩，則為濕滯；浮而兼芤，則為失血；浮而兼數，則為風熱；浮而兼洪，則為狂躁。然總不越有力無力，有神無神，以為區別。若使神力俱有，是為有余，或為火發，或為氣壅，或為熱越，可类推也。神力俱無，是為不足，或為精衰，或為氣損，可因明也。豈可概指為表為熱乎。張景岳曰：凡浮大絃硬之極，甚至四倍以上者，內經謂之關格，此非有神之謂，乃真陰虛極，而陽亢無根，大凶兆也。林之翰曰：浮脉須知主里。凡內虛之症，無不兼浮。如浮芤失血，浮革亡血，內傷感冒，而見虛浮無力，癆瘵陰虛，而見浮大兼疾，火衰陽虛，而見渾渾革至，浮大有力。又如真陰竭于下，孤陽浮于上，脉必浮大而無力，按之微細欲絕者，當益火之源。豈可以脉浮不申虛實，而妄用發表之劑乎。

沉脉 沉則輕取不應，重按乃得。凡細小實伏牢

弱，皆屬沉類。不似實脈之舉指逼逼，伏脈之隱于筋骨也。語出張璐。又瀕湖體狀詩曰：水行潤下脈來沉，筋骨之間軟滑勻；女子寸兮男子尺，四時號此為和平。相類詩曰：沉幫筋骨自調勻，伏則推筋着骨尋；沉細如綿真弱脈，弦長實大是牢形。沉為痰寒不振，水氣內伏，停飲不化，宿食不消，氣逆不通，洞泄不閉，故見內沉。若使沉而兼細，則為少氣；沉而兼迟，則為痼冷；沉而兼滑，則為宿食；沉而兼伏，則為霍亂絞痛；沉而兼數，則為內熱；沉弦而緊，則為心腹疼痛。然總不越有力無力，以為辨別。蓋沉實有力，宜消宜攻；沉虛無力，宜溫宜補。然亦有有力宜溫，無力宜攻，另有義詳于后，當細互參。若使沉緊而數，又兼頭痛發熱惡寒，雖曰脈沉，仍屬寒蔽，當作表治。豈可概認為里，而不用以升發乎。張璐曰：脈顯陰象而沉者，則按久愈微。若陽氣郁伏，不能浮應衛氣于外，脈反伏匿而沉者，則按久不衰。陰陽寒熱之機，在乎纖微之辨。傷寒以尺寸俱沉，為少陰受病。故于沉脈之中，辨別陰陽為第一關鍵。林之翰曰：沉脈須知主表。如寒閉腠理，衛氣不通，經氣滯滯，脈不見浮而沉；氣郁脈閉，下手便見，而脈亦沉；真陰久虛，真陽衰憊，外邪乘虛直入，而脈亦沉；是沉仍屬表症。

數脈 數則呼吸定息每見五至六至，應指甚速。

凡滑動緊促四脈皆屬數類。不似滑脈之往來流利，動脈之厥厥動搖，疾脈之过于急疾也。語出張璐。又瀕湖體狀詩曰：數脈息間常六至，陰微陽盛必狂煩；浮沉表里分虛實，惟有童兒作吉看。又相類詩曰：數比平人多一至，緊來如數似彈繩；數而時止名為促，數見關中動脈形。又曰：七至為極為疾，八至為脫，九至為絕。數為

寒熱內搏，風火沖激。是以人見數脈，多作熱治。詎知脈有真假，數有虛實，仍須察其兼症兼脈（眼意周到），及脈有力無力，以為分耳。若使數兼洪滑，且極有力，或是內熱蒸騰，伏火發動，當作實看。如系細小強滑細數綿軟，縱有身熱，須宜溫治。或引陽歸陰，其數自平；或補精化氣，其數自除；或溫中發表，其氣自舒；或宣壅去滯，其數自消。矧有并無熱候，症有虛寒，脈見虛數，溫補尚恐不及，其可以數為熱，妄用苦寒之味乎。景岳曰：里數為熱，而真熱者未必數。凡虛損之症，陰陽俱困，氣血張皇，多有是候。林之翰曰：數脈須知主寒。如脈浮數大而無力，按之豁然而空，此陰盛逼陽外浮，是寒焰也。醫家竟不審病新久，有力無力，鼓與不鼓，一概混投寒劑，遽絕胃氣，可不畏哉。

遲脈 遲則呼吸定息不及四至，舉按皆遲。凡代瀦結伏，皆屬遲類。不似瀦脈之三五不調，緩脈之去來徐緩也。語出張璐。又瀕湖詩曰：遲來一息至惟三，陽不勝陰氣血寒；但把浮沉分表里，消陰須益火之原。又相類詩曰：脈來三至名為遲，少於遲作緩持；遲細而難知是瀦，浮而遲大以虛推。又曰：二至為敗。遲為虛寒不振，陽氣不舒，故見遲滯。若遲而見浮，則為表寒；遲而見沉，則為里寒；遲而見瀦，則為血病；遲而見滑，則為氣病；遲兼滑大，則多風痰頭痺；遲兼細小，則為真陽虧弱；或陰寒留蓄而為泄瀉，或元氣不營于表而寒慄拘攣，總皆元氣虧損，不可妄施攻擊。然亦有熱邪內結，寒氣外郁，而見氣口脈遲者；又有陽

明臍症悉具，而見脉迟有力者；又有太陽脉浮。因誤下結胸，而見脉迟者；又有余熱未清，而脉多迟滯。总在知脉起止，及察症候以分虛實，詎可一見脉迟，便認為寒，而不究其滑濇虛實之異哉。景岳曰：迟虽为寒。凡伤寒初退，余熱未清，脉多迟滑，見迟不可以概言寒。林之翰曰：迟脉須知主熱。如熱邪壅結，隧道不利，失其常度，脉反變迟。又云：辨脉必須合症審察。如舉按無力，是主寒之迟脉；舉按有力，症兼胸膈飽滿，便閉溺赤，是主熱之迟脉。濇滯正是熱邪蘊結于內，致經脉濇滯而行迟也。

長脉 長則指下迢迢，上溢魚际，下通赤澤，过于本位，三部舉按皆然。凡實牢弦緊，皆屬長類。不似大脉舉之盛大，按之少力也。語出張璐。又瀕湖體狀相類詩曰：过于本位脉名長，弦則非然但滿張；弦脉與長爭較遠，良工尺度自能量。李士材曰：狀如長竿，直上直下，首尾相應，非若他脉上下參差首尾不勻者也。長為氣治無病之象，經曰：長則氣治。然必長而和緩方為無病。若使長而浮盛，其在外感，則為經邪方張；內損，則為陰氣不足而脉上盛。至于風邪陷陰，脉應微濇；乃于陰脉微細之中，而忽兼有長脉，是為熱邪外發，而有將愈之兆矣，又豈可作病進之象乎。仲景曰：太陰中風，四肢煩疼，陽脉微陰脉濇而長者為欲愈。

短脉 短則寸上尺下，低于寸尺。凡微濇動結，皆屬短類。不但小脉之三部皆小弱不振，伏脉之獨伏匿不前也。語出張璐。又瀕湖體狀相類詩曰：兩頭縮縮名為短，濇短迟迟細且難；短濇而浮秋喜見，三春為賊有邪干。短則止見尺寸。

若关中見短，則上不通寸为陽絕，下不通尺为陰絕矣，故关从無見短之理。盛同文云，关不見短。李士材曰，短脉只見于尺寸。然尺寸可短，依然落于陰絕陽絕矣；殊不知短脉非兩头断絕也，特兩头俯而沉下，中間突而浮起，仍自貫通者也。短为陽气不接，或中有痰气食积而成。然痰气食积阻碍气道，亦由陽气不力，始見阻塞。故凡見有阻塞之症者，当于通豁之內加以扶气之品，使气治而豁自見矣。若使中無阻塞而脉見短隔，急当用大溫补以救垂絕，否則便尔不治矣。

大脉 大則应指滿溢，既大且長，按似少力。凡浮芤洪長，皆屬大类。不似長脉但長不大，洪脉既大且數也。張璐大有虛实陰陽之異，不可一律。如見大而有力，則为陽气有余，其病則进；大而無力，則为正气不足。大偏于左，則为邪盛于經；大偏于右，則为热盛于陰。大而兼濇兼芤，則为血不內营；大而兼实兼沉，則为实热內熾。大而浮紧，則为病甚于外；大而沉短，則为痞塞于內。大实而緩，虽剧且生；大实而迫，虽靜即死。故凡脉大，必得症与脉应，方云無碍。若使久虛而見脉大，利后而見脉大，喘止而見脉大，产后而見脉大，皆为不治之症矣。張璐曰，諸脉皆小，中有一部独大者，諸脉皆大，中有一部独小者，便以其部断其病之虛实。

小脉 小則三部皆小，而指下显然。凡微細短弱，

皆屬小類。不似微脉之微弱依稀，細脉之微細如髮，弱脉之軟弱不前，按之乃得短脉之首尾不及也（張璠）。小为元气不足，及病已退之勢。如因病損小，其脉兼弱，見于人迎，則为胃气衰也；見于气口，則为肺气弱也；見于寸口，則为陽不足也；見于尺內，則为陰不足也；此皆無力之象。若使小而有力，脉兼滑实，則为实热固結。然脉不至急强，四肢不逆，犹云胃气之未絕。若胃气既無，生气已失，其奚济乎。經曰：切其脉口滑小紧益沉者，病益甚在中。又曰：溫病大热而脉反細小，手足逆者死。显微曰：前大后小，則头痛目眩；前小后大，則胸滿短气。

洪脉 洪則既大且数，纍纍珠联，如循琅玕。来則極盛，去則稍衰（素問）。凡浮芤实大，皆屬洪类。不似实脉之举按逼逼，滑脉之軟滑流利，大脉之大而且長也。語出張璠。又瀟湖体狀詩曰：脉来洪盛去还衰，滿指滔滔应夏时；若在春秋冬月分，升陽散火莫狐疑。相类詩曰：洪脉来时拍拍然，去衰来盛似波瀾；欲知实脉参差处，举按弦長愒愒坚。診家正眼云：洪脉只是根脚闊大，却非硬坚。若使大而坚硬，則为实脉，而非洪脉矣。洪为火气燔灼。凡煩渴、狂躁、斑疹、腹脹、头疼、面热、咽干、口瘡、癰腫等症，靡不由此曲形。如見脉洪而浮，則为表热；脉洪而沉，則为里热；脉洪而滑，則为兼痰。至于陽亢之極而足冷尺弱，屢下而热勢不除，洪数不減，与脉浮而洪，身汗如油，泄瀉虛脫，脉見洪盛者，皆为难治，不可强也。經曰：形瘦脉多气者死。景岳曰：若

洪大至極，甚至四倍以上者，是即陰陽離絕關格之脉也。林之翰曰：凡久嗽久病之人，及失血下痢者，俱忌洪脉。

微脉 微則似有若無，欲絕不絕，指下按之，稍有模糊之象。凡細小虛濇，皆屬微类。不似弱脉之小弱分明，細脉之纖細有力也。語出張璐。又瀕湖体狀相类詩曰：微脉輕微瞥瞥乎，按之欲絕有如無；微為陽弱細陰弱，細比于微略較粗。微為陽氣衰微之候。凡种种畏寒、虛怯、脹滿、嘔吐、泄瀉、眩暈、厥逆并傷精失血等症，皆于微脉是形，治當概作虛治。語出景岳。又李士材曰：仲景云：瞥瞥如羹上肥狀，其軟而無力也。縈縈如蜘蛛絲狀，其細而難見也。輕取之而如無，故曰陽氣衰；重按之而欲絕，故曰陰氣竭。長病得之死，謂正氣將次滅絕也；卒病得之生，謂邪氣不至深重也。然有痛極脉閉，脉見沉伏，与面有熱色，邪未欲解，并陰陽俱停，邪氣不傳，而脉俱見微者。若以微為虛象，不行攻發，何以通邪氣之滯耶。必熱除身安，方為欲愈之兆耳。李時珍曰：輕診即見，重按如欲絕者，微也。往來如綫而常有者，細也。

实脉 實則舉按皆強，舉指逼逼。凡弦洪緊滑，皆屬實类。不似緊脉之逆急不和，滑脉之往來流利，洪脉之來盛去衰也。語出張璐。又瀕湖体狀詩曰：浮沉皆得大而長，應指無虛偏偏強；熱蘊三焦成壯火，通腸發汗始安康。相类詩曰：实脉浮沉有力強，緊如彈索動無常；須知牢脉幫筋骨，实大微弦更帶長。實為中外壅滿之象。其在外感而見脉實而浮，則有頭痛、發熱、惡寒、鼻塞、頭腫、肢体疼痛、癰毒等症可察；

脉实而沉，則有腹滿硬痛等症可察。內伤脉实洪滑，則有諸火、潮熱、癰疽、血瘀、痰飲、腹痛、喘逆等症可察；脉实沉弦，則有諸寒壅滯等症可察。更以气血諸实等症兼觀，則病情在我，而無可遁之病矣。但脉云实，尚有何虛；既有虛象，便不云实。总在医人診其脉气果实不实耳。实脉有寒实热实之分。但今人止知病有热实，而不知有寒实，殊为可惜。景岳云：火邪实者，洪滑有力，为諸实热等症；寒邪实者，沉弦有力，为諸痛滯等症。又曰：实脉有真假，真实者易知，假实者易誤，故必問其所因，而兼察形症，方是高手。

虛脉 虛則豁然浮大而軟，按之不振，如尋鷄羽，久按根底不乏不散。凡芤濡迟澹，皆屬虛类。不似芤脉之豁然中空，按之漸出；濡脉之軟弱無力，举指即来；散脉之散漫無根，重按久按，絕不可得也。語出張璐。又瀕湖体狀相类詩曰：举之迟大按之松，脉狀無涯类谷空，莫把芤虛为一例，芤来迟大如慈葱。虛为气血空虛之候。故浮而虛者为气衰，沉而虛者为火微，虛而迟者为虛寒，虛而数者为水涸，虛而澹者为血亏，虛而弦者为土衰木盛，虛而尺中微細小为亡血失精，虛而大者为气虛不斂。要皆分別施治，無有差錯，斯为之善。然总不可用吐用下，以致益見其虛矣。仲景云：脉虛者不可吐，腹滿脉虛复厥者不可下，脉陰陽俱虛熱不止者死。

緊脉 緊則往来勁急，狀如轉索，虽实不坚。脉紧有力，左右彈人，如絞轉索，如切緊繩。凡弦数之屬，皆屬紧类。

不似弦脉之端直如弦，牢革之強直搏指也。語出張璐。

又瀨湖体狀詩曰：舉如轉索切如繩，脉象因之得緊名；总是寒邪來作寇，內為腹痛外身疼。彙辨云：緊較于弦，更加挺勁之異。丹溪云：緊如二股三股糾合為繩，必旋轉而轉，始得緊而成繩。可見緊之為義，不獨縱有挺急，抑且橫有轉側也。緊為陰邪內閉。如脉見浮緊，則必見有頭痛、發熱、惡寒、咳嗽、鼻塞、身痛不眠表症。脉見沉緊，則必見有脹滿、厥逆、嘔吐、瀉利、心脇疼痛、風癇痲痺里症。然总皆是陽氣不到，以至如是耳。仲景云：曾為人所難，緊脉從何來？假令亡汗若吐，以肺里寒，故令脉緊也。假令欬者，坐飲冷水，故令脉緊也。假令下利，以胃中虛冷，故令脉緊也。

緩脉 緩則來去和緩，不疾不徐。凡虛濡微細，皆屬緩類。不似濡脉之指下綿軟，虛脉之營營虛大，微脉之微細而濡，弱脉之細軟無力也。語出張璐。又瀨湖体狀詩曰：緩脉阿阿四至通，柳梢裊裊颭輕風，欲从脉里求神氣，只在从容和緩中。李士材曰：緩以脉形寬緩得名，迟以至數不及為義。蔡氏曰：緩而和勻，不浮不沉，不大不小，不疾不徐，意思欣欣，悠悠揚揚，難以名狀者，此真胃氣脉也。若純緩不兼，猶經所謂但弦無胃氣則死，緩為平人正脉，無事醫治。若使緩而兼大，則為傷風；緩而兼細，則為濕痺；緩而兼濇，則為血傷；緩而兼滑，則為痰滯。尤必察其有力無力，以為區別。如使緩兼有力，則為有余，其症必見燥熱；緩軟無力，則為不足，其症必見虛寒。豈可一見是緩，便指屬虛，而不合症為之分別乎。景岳曰：緩脉有陰有陽，其義有三，凡从容和緩，浮沉得

中者，此自平人正脉。若緩而滑大者多實熱，如內經所言者是也。緩而遲細者多虛寒，即諸家所言者是也。林之翰曰：緩脉須知主熱。如脉長大而軟，來去寬縱不前，即張太素所謂如絲在經，不卷其軸之謂，是曰縱緩，主于熱也。

芤脉 芤則如指着葱，浮取得上面之葱皮，却顯弦大，中取減小空中，按之又着下面之葱皮而有根據。凡浮革弦洪，皆屬芤類。不似虛脉之瞥瞥虛大，按之豁然無力也。語出張璐。又瀕湖體狀詩曰：芤形浮大軟如葱，按之旁有中央空。火犯陽經血上溢，熱侵陰絡下流紅。相類詩曰：中空旁突乃為芤，浮大而遲虛脉呼，芤更帶弦名曰革，芤為亡血革寒虛。芤為血虛不能濡氣。其症必見發熱、頭昏、目眩、驚悸、怔忡、喘急、盜汗、失血、脫血。然或芤見微曲，則芤必挾瘀積阻滯。芤兼弦強搏指，症見血溢身熱，則芤又為真陰槁竭。所以芤挾瘀積阻滯，止屬一部兩部獨見。若至左右皆芤，或兼弦搏，定為必死之候，無足異也。

戴同父云：營行脉中，脉以血為形，芤脉中空，脫血之象也。

濡脉 濡則虛軟少力，應指虛細，如絮浮水，輕手乍來，重手乍去。凡虛微細弱，皆屬濡類。不似虛脉之脉大無力，微脉之微細如絲，弱脉之沉細軟弱也。語出張璐。又瀕湖體狀詩曰：濡形浮脉按須輕，水面浮綿力不禁，病後產中猶有葯，平人若見是無根。相類詩曰：浮而柔細知是濡，沉細而柔作弱持，微則浮微如欲絕，細來沉細近于微。註曰：浮細如綿曰濡，浮而極細如絕曰微，沉細如綿曰弱，沉而極細不斷曰細。濡為胃氣不充。凡內傷泄瀉自汗喘乏，多有是脉。張璐、士材論極精明，

謂其治宜峻補。不似陰虛脫血，純見細數弦強，欲求濡弱，絕不可得也。蓋濡脈之浮軟，與虛脈相類；但虛則浮大，而濡則弱小也。濡脈之細小，與弱脈相類；但弱在沉分，濡在浮分也。濡脈之軟弱，與微脈相類；但微則欲絕，而濡則力微也。濡脈之無力，與散脈相似；但散則從大而按之則無，濡則從小而漸至無力也。夫從小而漸至無力，氣雖不充，血猶未敗；從大而按之即無，則氣無所統，血已傷殘，陰陽离散，將何所恃而可望其生乎。由斯言之，則濡與散，不啻天淵矣。所以濡脈多責胃氣不充，或外感陰淫。故治宜溫補而不可用傷殘之藥耳。李士材曰：濡脈者，浮小而軟也。

弦脈 弦則端直而長，舉之應指，按之不移。凡滑大堅搏之屬，皆屬弦類。不似緊脈之緊急有力，狀如轉索彈手，革脈之弦大而數也。語出張璐。又溯湖體狀詩曰：弦脈迢迢端直長，肝經木旺土應傷；怒氣滿胸常欲叫，翳蒙瞳子淚淋浪。相類詩曰：弦脈端直如絲絃，緊則如繩左右彈，緊言其力絃言象，牢脈弦長沉伏間。蔡西山曰：陽搏陰為弦，陰搏陽為緊，陰陽相搏為動，虛寒相搏為革，陰陽分體為散，陰陽不續為代。弦為血氣不和，氣逆邪勝，積聚脹滿，寒熱脇痛，瘡痢疝瘵等症（景岳）。然總由于木盛土衰水虧而成。但以弦多弦少以証胃氣之強弱，弦實弦虛以証邪氣之虛實，浮弦沉弦以証表里之陰陽，寸弦尺弦以証病氣之升沉。無論所患何症，兼

見何脉，但以和緩有神，不乏胃气，虽弦無碍（張璐）。若弦而勁細強直，是無胃气，豈能治乎。戴同父曰：弦而軟，其病輕，弦而硬，其病重。李時珍曰：浮弦支飲外溢，沉弦懸飲內痛，瘧脉自弦，弦數多熱，弦迟多寒，弦大主虛，弦細拘急，陽弦頭痛，陰弦腹痛，單弦飲癖，雙弦寒瘕。若不食者，木來尅土，必難治矣。

弱脉 弱則沉細軟弱，舉之如無，按之乃得，小弱分明。凡微濡細小，皆屬弱類。不似微脉按之欲絕，濡脉按之若無，細脉之浮沉皆細也。語出張璐。又瀕湖体狀詩曰：弱来無力按之柔，柔細而沉不見浮，陽陷入陰精血弱，白头尤可少年愁。弱為陽气衰微。凡見是脉，必須用溫補以固其陽，以補胃气。然必兼滑而和，可卜胃气之未艾。若弱更兼之以濇，并少壯暴病忽見是脉，則為气血交敗，多致難治。素問曰：脉弱以滑，是有胃气；脉弱以濇，是謂久病。病后老弱見之順，平人少年見之逆。仲景曰：陽陷入陰故惡寒發熱。又云：弱主筋，沉主骨。陽浮陰弱，血虛筋急。柳氏曰：气虛則脉弱，寸弱陽虛，尺弱陰虛，关弱胃虛。

滑脉 滑則往來流利，舉之浮緊，按之滑石。凡洪大芤實，皆屬滑類。不似實脉之逼逼應指，緊脉之往來勁急，动脉之見于一部，疾脉之過于急疾也。語出張璐。又瀕湖体狀詩曰：滑脉如珠替替然，往來流利却還前，莫將滑數為同類，數脉惟看至數間。滑為痰逆食滯，嘔吐上逆，痞滿壅腫滿悶之象。然亦以有力無力分辨。如系滑大兼數，其脉當作有余；若止輕浮和緩不甚有力，當不僅作有

余治也。或以氣虛不能統攝陰火，脈見滑利者有之；或以痰濕內積，而見脈滑者有之。至于平人脈滑而和，則為無病。婦人經斷而見滑數，則為有孕；臨產而見滑疾，則為離經。瀉痢而見弦滑，則為脾腎受傷；久病而弦滑，則為陰虛。豈可概作實治乎。李時珍曰：滑為陰氣有余，故脈來流利如水，脈者，血之府也。血盛則脈滑，故腎脈宜之；氣盛則脈濇，故肺脈宜之。

濇脈 濇則往來艰濇，動不流利，如雨沾沙，及刀刮竹。凡虛細微迟，皆屬濇類。不似迟脈之指下迟緩，緩脈之脈象紆徐，濡脈之去來綿軟也。語出張璐。又瀕湖體狀詩曰：細迟短濇往來難，散止依稀應指間；如雨沾沙容易散，病蚕食叶慢而艰。又相類詩曰：參伍不調名曰濇，輕如刮竹短而難，微似秒芒微軟甚，浮沉不別有無間。濇為氣血俱虛之候。故症多見拘攣麻木，憂郁，失血傷精，厥逆少食等症。然亦須分寒濇枯濇熱濇之殊耳。若濇見嘔吐泄瀉，則為屬虛屬寒；濇見傷精失血，拘攣麻木，則為枯濇不和；濇見便結不解，則為熱邪內閉，或寒滯不通。總在因症考求，豈可概指血虛，而不分別申顧乎。提出寒濇熱濇枯濇三種，則看病施治自有主腦。

動脈 動則厥厥動搖，滑數如珠，見于关上。凡浮大浮數，皆屬動類。不似滑脈之諸部皆見滑數流利也。語出張璐。又瀕湖詩曰：動脈搖搖數在關，無頭無尾豆形圓；其原

本是陰陽搏，虛者搖兮勝者安。動為陰陽相搏之候。王字泰曰：陽升陰降，二者交通，安有動見。惟夫陽欲降而陰逆之，陰欲升而陽逆之，兩者相搏，不得上下，鼓击之势，隴然高起，而動脈之形著矣。此言不雷與動脈傳神。如動在於陽，則有汗出為痛為驚之症；動在於陰，則有發熱失血之症；動兼滑數浮大，則為邪氣相搏而熱宜除。至于陽虛自汗而見動寸，陰虛發熱而見動尺，與女人動尺而云有孕，皆不宜作熱治矣。仲景曰：動則為痛為驚。素問曰：陰虛陽搏謂之崩。又曰：婦人手少陰心動甚者，娠子也。

伏脈 伏則匿于筋下，輕取不得，重按滯難，委曲求之，或三部皆伏，一部獨伏，附着于骨而始得。凡沉微細短，皆屬伏類。不似短脈之尺寸短縮而中部顯然，沉脈之三部皆沉而按之即得也。語出張璐。又瀨湖休狀特曰：伏脈推筋着骨尋，指間裁動隱然深，傷寒欲汗陽將解，厥逆膈疼証屬陰。伏為阻隔閉塞之候。或火閉而伏，寒閉而伏，氣閉而伏。其症或見痛極疝瘕，閉結氣逆，食滯忿怒，厥逆水氣。仍須詳其所因，分其為寒為火，是氣是痰，是新是舊，而甄別之。蓋有火者升火為先，有寒者疏寒為急，有氣者調氣為順，有痰者開痰為妥。新則止屬暴閉，可以疏通；久則恐其延綿，防其漸脫。豈可一見脈伏。而即妄用疏導乎。時珍曰：傷寒一手脈伏曰單伏，兩手脈伏曰雙伏，不可以陽症見陰為診。乃火邪內郁，不得發越，陽極似陰，故脈伏，必有大汗乃解。正如久旱將雨，六合陰晦，雨後庶物皆蘇之義。又有夾陰傷

寒，先有伏陰在內，外復感寒，陰盛陽衰，四脉厥逆，六脉沉伏，須投姜附及灸关元，脉乃复出也。若大谿冲陽皆無脉者死。

促脉 促則往来数疾，中忽一止，复来有力。凡疾数代結，皆屬促类。不似結脉之迟緩中有止歇也。語出張璐。又瀕湖体狀詩曰：促脉数而时一止，此为陽極欲亡陰；三焦郁火炎炎盛，进必無生退可生。促为陽邪內陷之象。凡表邪未尽，邪併陽明，暨里邪欲解，并傳厥陰者，多有是脉，故病必見胸滿下利厥逆。且有血瘀發狂，痰食凝滯，暴怒氣逆，亦令脉促。若中虛無凝，脉自舒長，曷为而有止歇之象乎。李士材曰：数而有止曰促，豈非陽盛者歟。肺癰熱毒，皆火極所致者。

結脉 結为指下迟緩中有歇止，少頃复来。凡迟緩代瀯，皆屬結类。不似代脉之动止不能自还也。語出張璐。又瀕湖体狀詩曰：結脉緩而时一止，独陰偏盛欲亡陽；浮为气滯沉为积，汗下分明在主張。結是气血漸衰，精力不繼，所以斷而復續，續而復斷。凡虛勞久病，多有是症，然亦有陰虛陽虛之別。故結而兼緩，其虛在陽；結而兼数，其虛在陰。仍須察結之微甚，以觀元氣之消長。若使其結过甚，脉甚有力，多屬有熱，或气郁不調。治宜辛溫扶正，略兼散結開痰，其結自退。至有一生而見結脉者，此是平素異常，不可竟作病治耳。結脉有虛有實。虛如景岳所謂血气漸衰，精力不繼，所以斷而復續，續而復斷者是也。實如越人所謂結甚則积甚者是也。

革脉 革則弦大而數，浮取強直，而按則中空。

凡芤牢緊脉，皆屬此類。不似緊脉按之劈劈，弦脉按之不移，牢脉按之益堅也。語出張璐。又瀕湖體狀詩曰：革脉形如按鼓皮，芤弦相合脉寒虛；女人半產并崩漏，男子營虛或夢遺。革為變革之象。凡亡血失精，腎氣內憊，或虛寒相搏，故脉少和柔，而有中空之狀。若不固腎補精，舒木除寒，而以革浮屬表，妄用升發，其不眞陰告絕者鮮矣。仲景曰：弦則為寒，芤則為虛，寒虛相搏，此名曰革，男子亡血失精，婦人半產漏下。經曰：三部脉革，長病得之死，卒病得之生。

牢脉 牢則弦大而長，按之強直搏指，狀如弦縷。

凡實伏弦濇，皆屬此類。不似實脉之滑實流利，伏脉之隱伏濇難。革脉之按之中空也。語出張璐。又瀕湖詩曰：弦長實大脉來堅，牢位常居沉伏間；革脉芤絃自浮起，革虛牢實要詳看。沈氏曰：似沉似伏，牢之位也；實大弦長，牢之體也。牢脉不可混于沉脉伏脉，須細辨耳。沉脉如綿裹沙，內剛外柔，然不必兼大弦也。伏脉非推筋至骨不見其形。在于牢脉既實大弦長，才重按之，便滿指有力，以為別耳。牢為堅積內着，胃氣將絕之候。吳草廬曰：牢為寒實，革為虛寒。故或見為濕痙拘急，寒疝暴逆，堅積內伏，治甚非易。倘不申其所因，而謂牢為內實，用以苦寒，或因思食而以濡滯恣啖，則其病益固矣。李時珍曰：牢主寒實之病，木實則為痛。扁鵲云：軟為虛，牢為實。失血者脉宜沉細，反浮大而牢者死，虛病見實脉也。張仲景曰：寒則牢固。有堅固之義。

疾脉 疾則呼吸之間脉七八至。凡動滑洪數，

皆屬疾類。不似洪脉之既大且數，却無燥疾之形也。疾似亢陽無制，亦有寒熱陰陽真假之異。若果疾兼洪大而堅，是明真陰垂絕，陽極難遏。如系按之不鼓，又為陰邪暴虐虛陽發露之征。然要皆屬難治，蓋疾而洪大者苦煩滿，疾而沉數者苦腹痛，皆為陰陽告絕。惟暴厥暴驚脉見急數，俟平稍愈為無碍耳。其有脉惟見疾而不大不細，則病虽困可治。東垣治傷寒脉疾，面赤目赤，煩渴引飲而不能咽，用姜附人參汗之而愈。守真治傷寒蓄熱陽厥，脉疾至七八至以上，用黃連解毒治之而安。

細脉 細則往來如髮，而指下顯然。凡弱小微濡，皆屬細類。不似微脉之微弱模糊也。語出張璐。又瀕湖體狀詩曰：細來柔細如絲，應指沉沉無絕期，春夏少年俱不利，秋冬老弱却相宜。細為陽氣衰弱之候。然細亦有分別，如細而兼浮，則為陽氣衰弱；細而兼沉，則為寒氣內中，或熱傳三陰；細而兼緩，則為濕中于內。皆當求其所因，不可混同施治。但脈既細如髮，便屬氣虛，縱有內熱，亦當兼固中氣，不可純用解熱，以致其細益甚耳。況有內熱全無，真元素虧，神氣不持，而致脈見細象者乎。李士材曰：嘗見虛損之人脉細身熱，醫不究原，而以涼劑投之，使真陽散敗，飲食不進，上嘔下泄，是速其斃耳。經曰：少火生氣。人非此火，無以運行三焦，熟腐水谷。未微乎此者，烏可以言醫哉。然虛勞之脉，細數不可并見，并見者必死。細則氣衰，數則血敗，氣血交勞，短期將至。

代脉 代則动而中止，不能自还，因而复动，名曰代陰。凡促結等脈，皆屬此类。不似促結之虽見歇止，而复来有力也。語出張璐。又瀕湖体狀詩曰，动而中止不能还，复动因而作代看；病者得之犹可序，平人却与寿相关。相类詩曰，数而时止名为促，緩止須將結脉呼；止不能回方为代，結代生死自殊途。代为元气垂絕之候。戴同父曰，代为脾絕之征，脾主信，故止歇有时。故無病而見脈代，最为可危。即或血气驟損，元神不續，或七情太过，或顛仆重伤，并形体賦时經隧有阻，流行蹇滯，而見脈代者，亦必止歇不勻，或云可治。若使歇止有常，則生气已絕，安望其有再生之日乎。惟妊娠惡阻嘔吐最劇者，恒見代脈，谷入既少，血气尽并于胎，是以脈气不能接續。然在初时或有，若至四月胎已成形，当無歇止之脈矣。李时珍曰，脉一息五至，五臟之气皆足。故五十动而一息，合大衍之数，謂之平脉；反此則止乃見焉。腎气不能至，則四十动一止；肝气不能至，則三十动一止。盖一臟之气衰，則他臟之气代至也。

散脉 散則举之散漫，按之無有，或如吹毛，或如散叶，或如悬雍，或如羹上肥，或如火薪然，来去不明，根蒂無有。不似虛脈之重按虽虛，而不至于散漫也。李瀕湖体狀詩曰，散似楊花散漫飞，去来無定至难齐；产为生兆胎为墮，久病逢之不必医。难經曰，散脉独見則危。散为元气离散之象，腎絕之应。盖腎脈本沉，而脈按之反見浮散，是先天之根本已絕，如伤寒欬逆上气，脈見散象必死，与經言

代散則死之意。即書有言熱退而身安，泄利止而漿粥入，云或可生，亦非必定之辭耳。散為死脈，故不主病。

奇經八脈 至于奇經八脈，又為十二經之約束。若臟氣安和，經脈調暢，八脈不形；即經絡受邪，不致滿溢奇經。惟是正經邪溢，轉入于奇。故內經有言：冲則直上直下（弦長）而中央牢（堅實），病苦逆氣里急（屬寒實）。督則直上直下（弦長）而中央浮（中央同尺寸浮起，非中央獨浮意也），病苦脊強不能俛仰（屬風）。任則脈橫寸口（寸口統寸關尺三部而言），邊丸丸（形如豆粒）緊細而長，病苦少腹切痛，男子內結七疝，女子帶下積聚（屬寒實）。陽維則尺內斜上至寸而浮（從左尺斜向小指，至寸而浮，曰尺內），病則寒熱溶溶不能自收持（屬陽）。陰維則尺外斜上至寸而沉（從右尺斜向大指，至寸而沉，故曰尺外），病苦心痛悵然失志（屬陰）。陽蹻（主陽絡）寸口左右彈浮而細綿綿（兩寸浮緊而細），病苦陰緩而陽急（邪在陽絡主表，如腰背苦痛之類）陰蹻（主陰絡）尺內左右彈沉而細綿綿（兩尺沉緊而細），病苦陽緩而陰急（邪在陰絡主里，如少腹痛陰疝漏下之類）。帶脈中部左右彈而橫滑（兩關滑緊），病苦腹痛腰溶溶若坐水中（邪在中）。凡此八脈，每遇五癰七疝，項瘕背強，發歇不時，內外無定之症，剛勁不倫，殊異尋常之脈，當于奇經中求之。經脈直行上下，絡脈斜行左右；經脈常升主氣，絡脈常降主血；經起中焦，隨營氣下行而上，故診在寸；絡起下焦，隨營氣上行極而下，故

診在尺。正經邪溢滿奇，越人比之天雨降下，溝渠溢滿，滂霈妄行，流于湖澤，誠哉是言也。

冲阳等脉 外此冲陽、太谿、太冲，皆足动脉。冲陽者，胃脉也。在足面上五寸骨間 动脉上去陷谷三寸。盖土者，万物之母。冲陽脉見不衰，胃气尙存，病虽危而犹可生也。然亦忌弦急，恐其肝旺尅土耳。太谿者，腎脉也，在足跗后兩傍圓骨上动脉陷中。盖水者，天一之元，診此不衰，尙可治也。太冲者，肝脉也，在足大指本节后二寸陷中。肝为东方生物之始，不衰則病可治。然此三脉，止可診此以定生死。若云可推某病，則無是也。至于高章綱卑慄損之脉，止是就其脉象而名。盖以高章綱为脉上行上浮滿溢搏指，卑慄損为脉下行下沉卑屑隱濇不振，仍是一陰一陽之意而別其名。至于太素一脉，古人傳而不言，言而不傳，皆有义存。以其語涉荒唐，而不輕語以欺世耳。

今之江湖术士，多借此法取錢。

五臟死脉 若使診心而見前曲后居，如操帶鉤，是为心死；診肺而見如物浮水，如風吹毛，是为肺死；診肝而見急益勁如新張弓弦，是为肝死；診脾而見銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，是爲脾死；診腎而見發如奪索，辟辟如彈石，是为腎死；与診命門而見魚翔蝦遊湧泉，是为命死；此五臟必死之脉

也。脉象如此。諸脉形象止是。

对待 然究众脉而論，則浮与沉，一升一降之謂也；數与迟，一急一慢之謂也；疾則較數而更甚矣。滑与濇，一通一滯之謂也；实与虛，一剛一柔之謂也。長与短，一盈一縮之謂也；大与小，一粗一嫩之謂也；細則較小而愈極矣。紧与緩，一張一弛之謂也；革与牢，一空一实之謂也；动与伏，一出一处之謂也；洪与微，一盛一衰之謂也；促与結，一陰一陽之謂也。至于弦与朮比，則脉之盛衰見矣；濡与弱比，則脉之进退見矣；代與散比，則死之久暫卜矣。脉之对待如斯。对待既明，則病陰陽表里虛实可知。

比类 洪与虛虽屬皆浮，而有有力無力之分；沉与伏虽应重按，而有着筋着骨之異。數以六至为名，紧則六至不及，疾則六至更过，弦則左右双彈，狀如切紧繩也。迟以三至为名，緩則仍有四至而徐徐不迫。实与牢本兼弦与長，而实則浮中沉俱有，牢則止于沉候見矣。洪与实皆为有力，然洪則重按少衰，实則按之益强矣。革与牢皆大而弦，而革以浮見，牢以沉見矣。濡与弱微，皆細而軟，然濡以浮見，弱以沉見，而微則以浮沉俱見矣。細与微，皆屬無力，而細則指下分明，微則模糊不清。短与动，皆無头尾，而短为陰脉，其来迟滯；动为陽脉，其来滑數矣。促結濇代，皆有一

止，而促則數時一止，結則緩時一止。濇則往來遲滯似歇，代則止有定數矣。脈形比類，又屬如斯。比類既明，則諸疑脈可辨。

綱目 以脈大綱小目而論：凡脈有言形体，曰洪、曰散、曰弦、曰革、曰肥、曰橫，是即大脈之屬也。有言形体，曰細、曰微、曰弱、曰瘦、曰縈縈如蜘蛛，是即小脈之屬也。有言至數，曰疾、曰急、曰動、曰促、曰击、曰搏、曰躁、曰喘、曰奔越無倫者，是即數脈之屬也。有言至數，曰緩、曰代、曰結、曰脫、曰少氣、曰不前、曰止、曰歇、曰如瀉膝之絕者，是即遲脈之屬也。有言往來之象，曰利、曰營、曰啄、曰翕、曰章、曰連珠、曰替替然，是即滑脈之目也。有言往來之象，曰緊、曰滯、曰行遲、曰脈不應指，曰參伍不齊、曰難而且散、曰如雨沾沙、曰如輕刀刮竹，是即濇脈之目也。有言部位之則，曰高、曰慄、曰涌、曰端直、曰條達、曰上魚為溢，是皆長脈之目矣。有言部位之則，曰抑、曰卑、曰不及指、曰入尺為復，是皆短脈之目矣。有言舉按之則，曰扎、曰毛、曰泛、曰盛、曰肉上行、曰時一浮、曰如水漂木、曰如循榆莢、曰瞥瞥如羹上肥，是皆浮脈之目矣。有言舉按之則，曰伏、曰潛、曰堅、曰過、曰減、曰陷、曰獨沉、曰時一沉、曰如綿裹砂、曰如石投水，是皆沉脈之目矣。且綱之大者，曰大、曰數、曰長、曰浮、陽之屬

也。綱之小者，曰迟、曰濇、曰短、曰沉、陰之屬也（盧子由）。脉之綱目如斯（綱目既明，則脉自有所歸）。

以脉主病 以脉主病而論：則浮為風，緊為寒，虛為暑，濡為濕，數為燥，而脉火，此六淫應見之脉也。喜傷心而脉散，怒傷肝而脉急，恐傷腎而脉沉，驚傷胆而脉動，思傷脾而脉短，憂傷肺而脉濇，悲傷心而脉促，此七情受傷之脉也。脉之主病如是。主病既明，則治自有定斷。

脉眞从脉 然總不越陰陽虛實為之條貫。蓋脉之實者，其症必實（仍有寒實熱實之分）；脉之虛者，其症必虛（仍有火衰水衰之別）。若使脉實而症不實，非其所假在症，即其所假在脉也；脉虛而症不虛，非其所假在脉，即其所假在症也。如外虽煩熱而脉見微弱者，必火虛也。腹虽脹滿而脉見微弱者，必胃虛也。虛火虛脹，其堪取乎。此宜从脉之虛，不宜从症之實也。症即外寒而脉見滑數者，必假寒也。利即清水而脉見沉實者，必假利也。假寒假利，其堪取乎。此宜从脉之實，不宜从症之虛也。然症實有假，而症虛無假。假實者病症莫測，必須旁求他症，及以脉候，其假始出。若使症屬虛候，其症即知。縱有假寒假利，貌若虛象難明。然仔細考求，其寒止屬外見，而內必有煩躁等症。利即清水，而內必有燥糞，其水止从旁流，脉必滑

数有力，仍与寔脉寔症相似，宁曰症有假虚，而脉可不深信哉。

症真从症 凡此脉真無假，可以症应。若使專以脉求，而症竟不察識，則脉尚有难言者耳。何則？仲景云：伤寒脉浮大，邪在表，为可汗。若脉浮大，心下鞅，有热屬臟者攻之，不令發汗。此又非浮为表邪可汗之脉也。又云：脉促为陽盛，宜用干葛黄芩黄连湯。若脉促厥冷为虛脫，非灸非溫不可。此又非促为陽盛之脉也。又曰：脉迟为寒，脉沉为里，若陽明脉迟不惡寒身体濈濈汗出，則用大承气湯。此又非諸迟为寒之脉矣。少陰病始得之反發熱而脉沉，宜麻黄附子細辛湯微汗之。此又非沉为在里之脉矣。

脉見有力無力难憑 即書有言病症虛实，止在脉之有力無力，以为辨別。有力即屬有根。難經曰：上部有脉，下部無脉，其人当吐，不吐者死。上部無脉，下部有脉，虽困不害。所以然者，人之有尺犹树之有根，有根則不死。無力即屬無根。難經曰：寸口脉平而死者，生气独絕于內也。平即中饒不能建立之象，故曰死。

然試問其脉与症異，脉見堅勁有力，症見腹痛喜按，嘔逆战慄，其脉可作有余而用苦寒瀉实之藥乎。脉見虛軟無力，症見腹滿喘急痰鳴，其脉可作不足而用附桂理中之藥乎。且脉所鼓在气，而气动而不守，保無气自寒生，而气因寒而始振乎。脉之虛軟在湿，而湿滯

而不动，保無熱挾濕至，而脉因痰因濕而始軟乎。有力多因寒氣熱氣內結，但今人仅知熱氣內結為寔，而不知有寒氣內結為寔也。無力多因寒濕熱濕內軟，但今人仅知寒濕為痰為虛，而不知熱濕為痰為寔也。凡此當以望聞問數字并參。

脉兼望聞問同察 夫望聞問切，乃屬醫家要事。

若仅以脉為診，而致以寒為熱，以熱為寒，以表為里，以里為表，顛倒錯亂，未有不傷人性命者矣。況經所云脉浮為風，為虛，為氣，為嘔，為厥，為痞，為脹，為滿不食，為熱內結，類皆數十余症。假使診脉得浮，而不兼以望聞問以究其真，其將何以斷病乎。是以善診脉者，于人稟賦厚薄，或稟厚而純陽，或稟薄而純陰。或稟不厚不薄而平。形体肥瘦，彙辨云：肥盛之人氣居于表，六脉常帶浮洪；瘦小之人氣斂于中，六脉常帶沉數。身長之人下指宜疎，身短之人下指宜密。北方之人常見強寔，南方之人常見軟弱。少壯之人脉多大，老年之人脉多虛。醉后之脉常數，飲后之人常洪。室女尼姑多濡弱，嬰兒之脉常七至。又曰：此道形氣之常，然形氣之中，又必隨地轉移，方能盡言外之妙也。顏色枯潤，或枯而竭，或潤而和。聲音低昂，或音低小而微，知其體陰病陰；或聲高昂而壯，知其體陽病陽。性情剛柔，或剛主陽，或柔主陰。彙辨云：性急之人，五至方為平脉；性緩之人，四至便作熱症。飲食嗜好，或喜氣厚之物，而知陽虛；或喜味厚之物，而知陰弱。及平日脉象偏純，或脉體偏靜而見六陰之脉，或脉體偏動而見六陽之脉。或脉體不動不靜而見至平之脉。仁齋曰：陽脉虽病在寒，常見浮洪；陰脉虽病在熱，常見微細。與今所患病症，是新是旧，或新由于外感，其脉疾數洪大；或旧由于內傷，其脉細小短澀。

是內是外，或在外感屬表易治，或在內傷屬里難治。是陰是陽，或陽主表、主上、主氣、主火，或陰主里、主下、主血、主水。并經醫士是否藥壞，或假寒而用熱藥以壞，假熱而用寒藥以壞，或標病而用本藥以壞，本病而用標藥以壞之類。靡不細為詳審。要法真在此處。但今病家多不由醫細察。宗稟曰：素問言凡治病，察其形氣色澤。視人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法。若患人脈病不相應，既不得見其形，醫止據脈供藥，其可得乎。今豪富之家，婦人居幃幔之內，復以帛蒙手臂。既無望色之神，听聲之聖，又不能盡切脈之巧，未免詳問。病家厭繁，以為術疎，往往得藥不服。是四診之術，不得其一矣，可謂難也。嗚呼！然后合于所診脈象，以斷病情，以定吉凶。斷要通盤會計，又要得其主腦。切勿頭痛斷頭，腳痛斷腳。如果病屬有余，其脈應見浮洪緊數；若使其脈無神，或反見沉微細弱，便非吉矣。病屬不足，其脈應見沉微細弱；若使其脈鮮胃，或反見洪大數急，則非吉矣。推之暴病脈應見陽，久病脈應見陰，亦何莫不應與病相符，而始可言順矣。靈樞動輸篇云：陽病而陽脈小者為逆，陰病而陰脈大者為逆。

脈以獨見為真 但持脈之道，既在下指靈活，令其脈脊與手指目相對。盧氏曰：診法多端，全憑指法捷取。蓋人之中指上兩節長，無名食指上兩節短，參差不齊。若按舉排指疎，則移越一寸九分之定位；排指密，又不及寸關尺之界分。齊截三指，斯中指翹出，而節節相對，節無不轉，轉無不活，以別左右，分表里，推內外，悉五臟，候浮中沉，此三指定位法也。及其位定，專指舉按，固得其真，不若獨指之無牽帶，別有低昂也。第惟食指肉薄而靈，中指則厚，無名指更厚且木。是必指端復起如綫者名曰指目，以按脈中之脊。無論洪大弦

革，即小細絲微，或有脊焉。眞如目之視物，妍醜畢具，故古人稱診脈曰看脈，可想見其取用矣。每見惜指甲之修長，用指厚肉分，或指節之下，以憑診視者，眞不啻目生頸腋胸脇間矣。尤須得要以求病根。

在未診時，誰不自認精明，謂其何部何脈，何脈何象。及至臨症就診，則既以浮爲風，而又若浮非浮而非風也。以緊爲寒，而又若緊非緊而非寒也。以洪爲火，而又若洪非洪而非火也。以數爲燥，而又若數非數而非燥也。以虛爲暑，以濡爲濕，而又若虛非虛，若濡非濡，而不可以暑濕名也。諸如此類，既莫能分，復以六部六脈，分斷考求，毫不相貫。分斷考求，最爲診家大弊，切嘆今時犯此甚多。如張璐謂人診脈，大似向泥人祈禱，有時靈應，有時不靈應。詎知病屬一理，脈自無二，得其一而脈斯可斷矣。得其脈之獨有所見，而脈又可斷矣。從獨字洗出脈要精義。蓋獨之義不一。如有以諸部無乖，或以一部稍乖者，是其受病在此，而可以獨名也。有以五臟五脈各應互見，而六部六脈偏見一臟之脈者，是其病根伏是，而更可以獨名也。獨義無過如斯。故內經三部九候論，則有獨大獨小獨疾獨遲獨熱獨寒之謂耳。如獨而強者，則爲病屬有余；獨而弱者，即爲病屬不足。獨而有力有神，其脈雖強而不爲過。有力尤須有神。李東垣曰：脈病當求其神之有與無，如六數七極熱也，脈中有力即有神也；三遲二敗寒也，脈中有力即有神也。熱而有神，當泄其熱，則神在焉；寒而有神，當去其寒，則神在矣。寒熱之脈，無力無神，將何恃而泄熱去寒乎。

林之翰曰：按東垣此論，深達至理。但以有力二字言有神，恐不足盡有神之妙。王執中曰：有力中帶光澤潤滑也。于解進矣。蕭子顯歌云：輕清穩厚肌肉里，不離中部象自然。則又有進焉。獨而和緩柔弱，其脉虽弱，而不為害。蓋假獨者易知，而真獨者難明。得其要以求其獨，則獨無不在；失其要以求其獨，則獨其莫得矣。又從要字一層，剝出精義。故善言獨者，早以陰陽之原，腎水為陰之原，腎火為陽之原。氣血之本，腎水為血之本，腎火為氣之本，脾胃倉廩又為生氣生血之本。以求獨之根。知其根，則知其要；知其要，則知其獨。繼以順逆之理，約註云：春夏洪大為順，沉細為逆；秋冬沉細為順，洪大為逆。男子左大為順，女子右大為順。凡外感症，陽病見陽脉為順，見陰脉為逆；陰病見陽脉亦為順。內傷症，陽病見陽脉為順，見陰脉為逆；陰病見陰脉為順，見陽脉為逆也。取舍之道，順之則取，如有根有神有胃之類；逆之則舍，如癱賊敗脫離絕之類。并脉上下来去至止，曉然于胸，以識獨之宜。滑氏曰：上者為陽，來者為陽，至者為陽；下者為陰，去者為陰，止者為陰也。上者，自尺部上于寸口，陽生于陰也。下者，自寸口下于尺部，陰生于陰也。來者，自骨肉之分而出于皮膚之際，氣之升也。去者，自皮膚之際而還于骨肉之分，氣之降也。應曰至，息曰止也。然后臨症施診，以求獨之所在（獨在取舍明，輕重曉），則獨存；以明獨之所至（獨至根蒂知，真假識），則獨出矣。故有見上為獨，而其獨偏在下也；見左為獨，而其獨偏在右也；見腑為獨，而其獨偏在臟也；見表為獨，而其獨偏在里也。此其獨可以意會（獨有左右逢源之趣），而不可以言傳；獨有難以盡言之妙。此其獨可以獨知（獨有化裁盡變之義），

而不可以共覺矣(独有独覺難与时師共言之理)。苟無独知之明,仅讀醫方捷徑、叔和脉訣,何能独知。独見之真,仅見一時之病,一方之病,何能独見。独守之固,仅守時師耳听之說,蔓衍湯方之書,何能独守。而曰惟我为独,又从独字推进一层,妙义旋生。独固是也,而恐則为独夫之独矣;独亦是也,而恐則为毒人之独矣。繡嘗謂醫有四失,一曰字句不曉,二曰涉獵湯方,三曰株守一書,四曰勦襲糟粕。凡此四失,必能毒人。其尚得謂真正之独,与因应化裁之独哉。故曰持脉之道,貴乎活潑(一語括尽)。若局守不变,則所向輒迷,又安能申独求真,而得病之所归者乎。

卷 二

新增四言脉要

繡按四言脉要,始于宋南康紫虛隱君崔嘉彥希范所著。盖以初学脉理未諳,得此可为誦習。故后新州李言聞、云間李士材、海鹽馮楚瞻,皆于己著集內,將此刪改,附刻篇末,業已行世。独惜尚有駁杂未清之处,爰取士材改本,加意增刪,俾文义簡明,脉症悉賅,庶讀者一覽而知。而不致有繁多缺陷之憾耳。

脉为血脉,百骸貫通。大会之地,寸口朝宗。

脉者,血脉也。血脉附气,周于一身,循环無間,故百骸皆資貫通,而寸口为各經諸脉大会之地。肺处至高,形如华盖,凡諸臟腑各經之气,無不上蒸于肺,而于寸口之地宗而朝之耳。

診人之脉，令仰其掌。掌后高骨，是名关上。

医者复手大指，着于病人高骨之处，随以中指对抵以定关部。至于尺寸，则以前后二指着定。如病人长，则下指宜疎；病人短，则下指宜密。

关前为陽，关后为陰。陽寸陰尺，先后推寻。

魚际至高骨止有一寸，故以寸名；尺澤至高骨却有一尺，故以尺名；关界尺寸之間，故以关名。經曰：身半之上，同天之陽；身半之下，同地之陰。故以关前之寸为陽以候上焦，关后之尺为陰以候下焦，关处前后之中以候中焦。凡診必先从寸至关，从关至尺，定其先后，以推其理而寻其象也。

胞絡与心，左寸之应。惟胆与肝，左关所認。膀胱及腎，左尺为定。胸中及肺，右寸昭彰。胃与脾脉，屬在右关。大腸并腎，右尺班班。男子之脉，左大为順。女人之脉，右大为順。男尺恒虛，女尺恒盛。

按古臟腑脉配兩手，皆以內經所立脉法为定，而不敢易。左为陽，故男左脉宜大；右为陰，故女右脉宜大。寸为陽，故男所盛在陽而尺恒虛；尺为陰，故女所盛在陰而尺恒盛。

人迎气口，上下对待。一肺一胃，經語莫悖。神門屬腎，在兩关后。

人迎脉在俠喉兩傍一寸五分，胃脉循于咽喉而入缺盆。凡胃脘之陽，是即人迎之气之所从出。故診人迎之脉，亦在右关胃脘胃陽之处，而可以卜在上头項外感之疾也。气口在于魚际之后一寸，肺朝百脉，肺主气，故診气口之脉，即在右寸肺臟肺陰之部，而可以卜在中在胸內伤之疾也。統論皆可以候臟腑之气，灵樞素問言之甚明，并無左右分診之說。叔和悖而更之，議之者多矣。人之精神，寄于兩腎。故兩腎脉無，則其神已灭，而無必生之候矣。

脉有七診，曰浮中沉，上下左右，七法推尋。

浮于皮毛之間輕取而得曰浮，以候肺氣。中于肌肉之間略取而得曰中，以候胃氣。沉于筋骨之間重取而得曰沉，以候臟氣。上于寸前一分取之曰上，以候咽喉中事。下于尺后一分取之曰下，以候少腹腰股脛膝之事。合之左右兩手共為七診，以盡其推尋之力焉。

又有九候，曰浮中沉。三部各三，合而為名。每部五十，方合于經。

五臟之氣各足，則五十動而一息，故候必以五十為準。每手三部各三，共為九候，合之應得四百五十之數，兩手共得九百之數。

五臟不同，各有本脉。左寸之心，浮大而散。右寸之肺，浮濇而短。肝在左關，沉而弦長。腎在左尺，沉石而濡。右關屬脾，脉象和緩。右尺相火，與心同斷。

五臟各有平脉，平脉即本脉。知其本脉無乖，而后知病脉之故也。

四時百病，胃氣為本。

胃為水谷之海，資生之本也。凡病診得脉緩和勻，不浮不沉，不大不小，不疾不徐，意思悠悠，便為胃氣。不拘四季，得食則生，不得則死。今人混將時令剋應推循過極，殊失胃氣之本矣。

凡診病脉，平旦為準。虛靜凝神，調息細審。

平旦飲食未進，經脉未動，絡脉調勻，氣血未亂，可診有過之脉。至于醫家亦須先無思慮，以靜以虛，調其息氣，凝神指下，精細詳察，以求病之所歸耳。

一呼一吸，合為一息。脉來四至，平和之則。五至無病，閏以太息。三至為遲，遲則為冷。六至為數，

數即熱病。轉遲轉冷，轉數轉熱。

醫以己之呼吸調勻定息。如一呼吸，得脈四至，是即和平之準則也。五至何以無病，蓋以人之氣息長短不定，每于三息五息之候，必有一息之長，故曰太息。如醫一息而見脈來五至，此非病脈之急，是醫氣息之長也，故五至不為有病。惟脈一息三至，即為遲慢不及；六至，即為急數太過。若至一至二至，則為轉遲轉冷；七至八至，則為轉數轉熱；而非壽生之脈矣。

遲數既明，浮沉須別。浮沉遲數，辨內外因。外因于天，內因于人。天有陰陽，風雨晦明。人喜怒憂，思悲恐驚。

天之六氣淫人，如風淫則病在末，陰淫則病在寒，明淫則病在暑，雨淫則病在濕，晦淫則病在燥，陽淫則病在火，是外因也。人之七情傷人，如喜傷心，怒傷肝，憂傷肺，思傷脾，恐傷腎，驚傷膽，悲傷心，是內因也。

浮表沉里，遲寒數熱。沉數里熱，浮數表熱。浮遲表寒，沉遲冷結。

此提浮沉遲數四脈之綱，以分在表在里寒熱各見之症也。

浮脈法天，輕手可得。泛泛在上，如水漂木。有力為洪，來盛去悠。無力為芤，有邊無中。遲大為虛，仔細推求。虛極則散，渙漫不收。浮小為濡，如綿浮水。濡甚則微，若有若無。更有革脈，芤弦合看。共是七脈，皆于浮候。

此以浮脈提綱，而取洪芤虛散濡微革七脈之兼乎浮者統繫于下也。浮脈应于肉分肌表，故輕手取之即見，正如木漂水面之意。洪脈來極盛大，按之有力，去則稍衰，正如波濤洶湧，來盛而去則悠耳。芤則浮沉易

見，而中豁然空虛，故有著葱之喻，亦非中候絕無，但比之浮沉二候，則覺無力。虛則雖浮且大，而按之無力，且更遲緩。散則虛浮無力，按之則無，正如楊花飄散，比于虛脈則甚。濡則浮小而軟，如綿浮水。微則浮取欲絕不絕，若有若無，較之濡脈軟小更極。革則浮多沉少，外急內虛，正仲景所謂弦則為寒，芤則為虛，虛寒相搏，其名曰革之意。

沉脈法地，如石在水。沉極則伏，推筋至骨。有力為牢，大而弦長。牢甚則實，幅幅而強。無力為弱，狀如細綿。細極為細，如蛛絲然。共是五脈，皆于沉看。

此以沉脈提綱，而取伏牢實弱細五脈之兼乎沉者彙于下也。沉脈应于筋骨，故必重按乃得，正如石之墜于水里之意。伏則沉之至極，故必推之筋骨始見。牢則沉大弦長，按之有力，不似革脈浮取強直，而中則空。實則三部皆堅，而力更甚于牢。弱則沉極細軟，却極分明。細則沉細直軟更甚于弱，故比狀如蛛絲。

遲脈屬陰，一息三至。有力為緩，少駛于遲。往來和勻，春柳相似。遲細為瀯，往來極滯。遲有一止，其名曰結。遲止有常，應作代看。共是四脈，皆于遲測。

此以遲脈提綱，而取緩瀯結代四脈之兼乎遲者統彙于下也。遲為往來迟慢，故一息而見三至。緩則往來和勻，軟若春柳，即是胃氣之脈。瀯則迟滯不利，狀如輕刀刮竹。代則迟而中止，不能自還，但止有定數，而不愆期。

數脈屬陽，一息六至。往來流利，滑脈可識。有力為緊，切繩極似。數時一止，其名為促。數如豆粒，動脈無惑。共為四脈，皆于數得。

此以数脉提綱，而取滑紧促动四脉之兼乎数者統集于下也。数則往来急数，故一息而見脉有六至。滑則往来無滯，有如珠之走盤。紧則紧急有力，狀如弦紧彈手，故有切繩之喻。数时一止为促，狀如疾行而蹶。数而兩头俱俯，中間高起，有似豆粒厥厥动摇。是謂之动。

別脉有三，長短与弦。不及本位，短脉可原。过于本位，長脉綿綿。長而端直，狀似弓弦。

此長短与弦三脉，非浮沉迟数可括，故別列于此。短者，上不通于魚际，下不通于尺澤，有短縮不伸之意。長者，通尺澤魚际，上下皆引，有迢迢过于本位之情。若弦則勁直不撓，有似弓弦，不似紧脉弦急彈人。

一脉一形，各有主病。脉有相兼，还須細訂。

有一脉之形象，必有一脉所主之病。有兼見之脉象，即有兼見之症，可細就其兼見之脉。以例其症耳。

浮脉主表，肺病所居。有力为風，無力血虛。浮迟表冷，浮数風热。浮紧風寒，浮緩風湿。浮虛伤暑，浮芤失血。浮洪虛火，浮微勞極。浮濡陰虛，浮散虛剧。浮弦痰飲，浮滑痰热。

浮虽屬陽，主表主肺，但浮而見洪数弦滑有力之脉，固屬主热主火主痰主風；若浮而見迟緩芤虛微濡与散無力之脉，又为主虛主湿主冷主暑主危之象矣。故脉当視所兼以为辨別。下文做此。

沉脉主里，为寒为积。有力痰食，無力气郁。沉迟虛寒，沉数热伏。沉紧冷痛，沉緩水畜。沉牢痼冷，沉实热極。沉弱陰虛，沉細虛湿。沉弦飲痛，沉滑食滯。沉伏吐利，陰毒積聚。

沉虽屬陰屬里，然沉而見迟紧牢緩細弱諸脉，方謂屬虛屬寒屬积屬

聚；若沉而見實數諸脈，則沉更不謂屬陰，又當自陰以制其火以除其熱也。

遲脈主臟，陰冷相干。有力為痛，無力虛寒。

遲雖屬陰，仍當以有力無力分其寒實寒虛。蓋寒實則為滯為痛，而寒虛則止見其空虛也。

數脈主腑，主吐主狂。有力實熱，無力虛瘡。

數雖屬陽，仍當以有力無力分其熱實熱虛。蓋熱實則必為狂為燥，而熱虛則止見其虛瘡耳。

滑司痰飲，右關主食。尺為畜血，寸必吐逆。澹脈少血，亦主寒濕。反胃結腸，自汗可測。

滑司痰飲，而亦有主食主血主吐之分。澹本血少，而亦有寒澹濕澹之別。但血枯則上必見反胃，而下必見腸結；腸結胃反，則水液自爾不行，而有上逆為汗之勢矣。

長則氣治，短則氣病。浮長風癰，沉短痞塞。

長為肝經平脈，故未病脈長，是為氣治。短即肺之平脈，若非右寸及于秋見，則必有氣損之病矣。至長獨于浮見，則為風火相搏而癰以生；短以沉見，則為虛寒相合而痞以成。

細則氣衰，大則病進。澹小陰虛，弱小陽竭。

脈以和平為貴。凡脈細如蛛絲之狀，其氣自屬衰弱；大而滿溢應指有力，是為病勢方張。至于三部皆小，較細顯極而脈澹不快，是為精血虛損。既小而脈不大，又脈痿弱不起，是為陽氣衰弱。皆當分別審視。

洪為熱極，其傷在陰。微為氣衰，其損在陽。浮洪表實，沉洪里實。陽微惡寒，陰微發熱。

洪為熱極，其傷在陰，但須分其表里。微為氣衰，其損在陽，亦須分其陽分陰分，以別惡寒發熱之治也。

紧主寒痛，有表有里。緩主平和，兼見須慮。緩滑痰湿，緩大風虛。緩澹血伤，緩細湿痺。

浮紧則为寒閉于表，必有身痛头痛惡寒等症可察。沉紧則为寒束于里，必有肚腹脹滿逆痛等症可察。緩为虛，大为風，緩大脉見則为風虛。緩为食停，細为气滯，緩細脉見，其痺必生。緩为气衰，澹为血損，緩而見澹，其損必甚。緩則湿滯不消，滑則痰飲內蓄，緩与滑見，則湿必停而痰益甚。

陽盛則促，肺癰熱毒。陰盛即結，疝瘕積郁。

數而有止为促，非陽盛乎，故有肺癰熱毒之症；迟而有止为結，非陰盛乎，故有疝瘕積郁之症。

弦脉主飲，木侮脾經。陽弦头痛，陰弦腹疼。動主搏击，陰陽不調。陽動汗出，为痛为惊。陰動則熱，崩中失血。

脉弦而土必虛，則湿自無土制而痰以生。故弦而在于寸，寸主上焦，其痛必在于头；弦在于尺，尺主下焦，其痛必在于腹。動为陰陽不和，動見于寸，則心肺受累而惊痛与汗自至；動見于尺，則腎水受累，而崩中失血自生。

虛寒相搏，其名曰革。男子失精，女子漏血。若見脉代，眞气衰絕。膿血症見，大命必折。伤寒霍乱，跌打悶絕。瘡疽痛甚，女胎三月。

革脉由于精血亏损，故尔脉空不实，而見男子失精女子漏血之症。至于脉代而絕，或膿血症見，未有不死。惟有伤寒霍乱，跌仆瘡疽，痛甚胎产見之，以其暴伤暴閉，勿作死治也。

脉之主病，有宜不宜。陰陽順逆，吉凶可推。

病有陰陽，脉亦陰陽，順應則吉，逆見則凶。下言脉症相应順逆，总

不出乎此理以为之貫通也。

中風之脉，却喜浮迟。堅大急疾，其凶可知。类中因气，身涼脉虛。类中因痰，脉滑形肥。类中因火，脉数面赤。

風有真中类中之各別。真中虽屬实症，而亦由虛所招，故脉喜其浮迟，而忌堅急，恐其正虛邪胜，决無生也。类中本非風中，特症相似而名，故症与脉各以类見。而不能以一致耳。

伤寒热病，脉喜浮洪。沉微濇小，症反必凶。汗后脉靜，身涼則安。汗后脉燥，热盛必难。始自太陽，浮紧而濇。及傳而变，名狀难悉。陽明則長，少陽則弦。太陰入里，沉迟必兼。及入少陰，其脉遂沉。厥陰热深，脉伏厥冷。陽症見陰，命必危殆。陰症見陽，虽困無害。中寒紧濇，陰陽俱紧。法当無汗，有汗伤命。

病陽脉宜見陽，病陰脉宜見陰。故伤寒热病之症，宜見洪数之脉，与伤寒汗后不宜見脉燥之象耳。即云寒邪傳变，名狀莫悉。与陰寒直中，陰陽俱紧，脉不一端。然大要陽得陰脉，脉与症反，命必危殆。若陰症而見浮大数动洪滑之陽，其脉虽与症反，在他症切忌，而伤寒邪气初解，病虽危困，亦未有害。惟伤寒汗出症虛，而脉反見陰陽俱紧，是其元气已脱，脉气不和，非吉兆也。

伤風在陽，脉浮而滑。伤風在陰，脉濡而弱。六經皆伤，或弦而数。陽不浮数，反濡而弱。陰不濡弱，反浮而滑。此非風寒，乃屬溫湿。若止濡緩，或兼細濇。此非風湿，更屬湿着。

風为陽邪，風伤則脉自有浮滑弦数之象。但風有伤于陰，則浮与滑

自不克見，以陽為陰所閉也。反是多因風為濕阻，故又名為風濕。如至浮數俱無，獨見濡緩細澹，定知為濕所淫，所當分別以視也。

陰陽俱盛，熱病之征。浮則脈滑，沉則數澹。中暑傷氣，所以脈虛。或弦或細，或芤或迟。脈雖不一，總皆虛類。

凡脈而見陰陽俱盛者，未有不因熱邪充溢之故。所以脈浮而滑，其熱必挾有飲。脈沉數澹，其熱必傷於陰。若暑則多氣虛不固，以致暑得內襲，而脈亦虛不振。即或體有不同，脈見芤弦細迟。然要皆屬虛類，而不可實攻耳。

瘟脈無名，變見諸經。脈隨病見，不可指定。

疫邪伏於募原，時出時沒，其脈變換不定，故但隨其所見以為指耳。

瘧則自弦，弦即瘧候。兼迟則寒，兼數則熱。代散脈見，其體則折。

瘧因風木邪盛凌土而濕不化，致挾停痰積飲而成，故脈始見自弦，再于兼見之中，別其寒熱酌治，則病自愈。惟代散脈見，則命其必絕矣。

風寒濕氣，合為五痺。浮澹與緊，三脈乃備。腳氣之脈，其狀有四。浮弦為風，濡弱為濕。迟澹為寒，洪數為熱。痛非外因，當于尺取。滑緩沉弱，隨脈酌治。

五痺腳氣等症，總不越乎風寒及濕三者以為之害。即或內淫為熱，亦不越乎四者以為之伏。惟有痛非外因，而脈或于尺部而見，或滑、或緩、或沉、或弱，則又在于隨脈酌施。而不可以風寒濕治也。

勞倦內傷，脾脈虛弱。汗出脈燥，治勿有藥。勞極諸虛，浮軟微弱。土敗雙弦，火炎則數。

虛症而見虛脈，此順候也。若汗出而脈反燥，是為大逆，尚有何藥

可治乎。故弦數最為虛症切忌。

痞滿滑大，痰火作孽。弦伏中虛，微瀦衰薄。脹滿之脈，浮大洪實。細而沉微，岐黃無術。水腫之症，有陰有陽。陰脈沉遲，陽脈洪數。浮大則生，沉細勿藥。五臟為積，六腑為聚。實強可生，沉細難愈。黃疸濕熱，洪數偏宜。不妨浮大，微瀦難醫。

痞脹水腫積聚黃疸，雖其病因不同，形症各別；然終宜見有余之脈，則真氣未絕，而治尚可愈矣。若至細小沉瀦，形實氣餒，將何有藥可施乎，故皆為逆。

郁脈皆沉，甚則伏結。或代或促，知是郁極。胃氣不失，尚可調治。氣痛脈沉，下手便知。沉極則伏，瀦弱難治。亦有沉滑，是氣兼痰。心痛在寸，腹痛在關。心腹之痛，其類有九。細迅速愈，浮大延久。兩脇疼痛，脈必雙弦。緊細而弦，多怒氣偏。沉瀦而急，痰瘀之愆。疝屬肝病，脈必弦急。牢急者生，弱急者死。腰痛之脈，必弦而沉。沉為氣滯，弦損腎元。兼浮者風，兼緊者寒。濡細則濕，寒則閃挫。頭痛之病，六經皆有。風寒暑濕，氣郁皆侵。脈宜浮滑，不宜短瀦。

弦急弦沉伏瀦緊細，皆是痛症氣症郁症本領。但痛極者，則脈必沉必伏。有痰者，則脈必瀦。因濕者，則脈必濡。因痰者，則脈必滑。因風者，則脈必浮必弦。因寒者，則脈必緊。因濕者，則脈必滯必弱。因熱者，則脈必數。因于痛極陰陽告絕者，則脈必疾。因于積極而痛者，其

脉必牢。須以胃氣不失為要。故痛症而見其脉浮大、最屬不宜；短濇弱急，亦屬不利；惟得沉緊遲緩乃治。但頭痛外感，非屬內傷，其脉又宜浮大，最忌短濇，所當分別而異視也。

嘔吐反胃，浮滑者昌。弦數緊濇，結腸者亡。飽逆甚危，浮緩乃宜。弦急必死，代結促微。吐瀉脉滑，往來不勻。瀉脉必沉，沉遲寒侵。沉數火熱，沉虛滑脫。夏月泄瀉，暑濕為殃。脉與病應，緩弱是形。微小則生，浮弦則死。霍亂之脉，代則勿訝。遲微厥逆，是則可嗟。泄瀉下痢，沉小滑弱。實大浮數，發熱則惡。

吐宜浮緩浮滑，瀉宜沉小沉滑，吐瀉交作，則脉必見往來不勻，虽暴見代勿慮。如其吐見弦急，瀉見浮弦，并吐瀉交作而見遲微厥逆，皆屬不治，故以必死為斷也。

釐雜噦氣，审右寸关。緊滑可治，弦急則難。吞酸之脉，多弦而滑。沉遲是寒，洪數是熱。痰脉多滑，浮滑兼風。沉滑兼寒，數滑兼熱。弦滑為飲，微滑多虛。滑而兼實，痰在胸膈。結乳濇伏，痰固中脘。

釐雜噦氣本屬脾氣不運，故切忌脉弦急，恐木尅土故也。吞酸有寒有熱、隨症所見以為分別，故以沉遲洪數分之。痰脉因不一端，滑是本象。惟有風則浮，有寒則沉，有熱則數，有飲則弦、虛弱則微，結于胸膈為實，固于中脘，則見結乳濇伏之為異耳。

小便淋秘，鼻色必黃。實大可疔，濇小知亡。遺精白濁，當驗于尺。結乳動緊，二症之的。微數精傷，洪數火逼。亦有心虛，寸左短小。脉遲可生，急疾便夭。

便結之脉，迟伏勿疑。熱結沉數，虛結沉迟。若是風燥，右尺浮起。

淋秘脉見澹小，精血已敗，死亡至矣，此脉見不及者之必死也。遺濁虽有微數洪數短小之分，然急疾脉至，又非所宜，故曰便天，此脉見太過者之必死也。若在便閉，里氣不通，固应迟伏，然風寒濕熱，當于脉迟脉數脉浮分辨，不可混同而罔治也。

咳嗽多浮，浮濡易治。沉伏而緊，死期將至。喘息抬肩，浮滑是順。沉澹肢寒，均为逆症。

咳嗽肺疾，脉浮为宜，兼濡亦为病氣將退。若使沉伏与緊，便与病反，故曰必死。喘症無非風痰內湧，當以浮滑为順。若至肢寒沉澹，亦非吉兆，故曰为逆。

火熱之脉，洪數为宜。微弱無神，根本脫离。三消之脉，數大者生。細微短澹，应手堪惊。骨蒸發熱，脉數为虛。熱而澹小，必損其軀。痿因肺燥，必見浮弱。寸口若沉，發汗則錯。

火症应見火脉，故三消骨蒸，須以數大为生。反是而見短澹微弱，豈其宜乎。痿症本因肺燥血亏，脉浮尚不宜汗，豈有宜于寸口脉沉之候乎。

諸症失血，皆見芤脉。隨其上下，以驗所出。脉貴沉細，浮大難治。蓄血在中，牢大則宜。沉細而微，速愈者稀。

失血脉宜見芤，以芤主空故也。故脉最宜沉澹而忌浮大，反是則逆矣。若至蓄血，最宜牢實而忌沉細，以血未損故也。反是峻劑莫投，故曰難愈。

心中惊悸，脉必代結。飲食之悸，沉伏動滑。癰

乃重陰，狂乃重陽。浮洪吉象，沉急凶殃。稠宜虛緩，沉小急實。若但弦急，必死不失。

惊悸非屬心氣虧損，即屬有物阻滯，故脈必見代結。若因飲食致悸，則有沉伏動滑之象，所當申也。癲狂二症為病尚淺，故宜浮洪而惡沉急，反是則為病氣入骨。痼宜虛緩，以其中有痰沫之故。弦急獨見，是為真臟脈出，安望其再生耶。

耳病腎虛，其脈遲濡。浮大為風，洪動為火。沉濡為氣，數實為熱。若久聾者，耑于腎責。暴病浮洪，兩尺相同。或兩尺數，陰虛上冲。齒痛腎虛，尺脈濡大。齒痛動搖，尺洪火炎。右寸關數，或洪而弦。非屬腎虛，腸胃風熱。口舌生瘡，脈洪疾速。若見虛脈，中氣不足。喉痺之脈，兩寸洪盛。上盛下虛，脈忌微伏。

耳病當責于腎，以其腎竅開于耳者故耳。然亦須以浮風、洪火、濡氣、數熱、久聾為辨。如其是暴非久，又以兩尺浮弦相同為驗耳。齒雖屬腎，而齒齦則屬于胃，故辨齒痛脈象，須以尺濡、尺洪斷其虛實，寸關洪數與弦，斷其腸胃風熱，未可盡以腎求也。口舌生瘡，必與洪疾為實，虛則多屬中氣不足。喉痺症屬上實，脈以寸盛為順。若見微伏，真氣已絕，故曰大忌。

中惡腹脹，緊細乃生。浮大為何，邪氣已深。鬼祟之脈，左右不齊。乍大乍小，乍數乍遲。中毒洪大，脈與病符。稍或微細，必傾其身。虫傷之脈，尺沉而滑。緊急莫治，虛小可怯。

中惡宜于緊細，以其邪氣未深之故；反是則邪盛正衰，非其宜也。

鬼祟出沒不定，故脉有難追求。中毒脉見洪大，是與病應，以毒主陽故也。稍見微細，眞氣絕矣，豈其宜乎。虫傷脉多沉滑，以其虫伏于內者故耳。緊急固見傷甚而陰陽隔離，虛小亦恐眞氣已損，皆爲有慮。

婦人之脉，尺宜常盛。右手脉大，亦屬順候。尺脉微迟，經閉三月。氣血不足，法當溫補。婦人尺脉，微弱而濡。年少得之，無子之兆。長大得之，絕孕之征。因病脉濇，有孕難保。

婦人以血為主，故尺宜常盛，而右脉宜大。故尺迟則經必閉，微弱而濇，在有孕固不克保，況無孕乎。

崩漏不止，脉多浮動。虛迟者生，實數者死。疝瘕之脉，肝腎弦緊。小便淋閉，少陰弦緊。

崩漏不止，已屬血動不歸，再見實數，則腎眞氣已絕，所以不宜見也。疝瘕主于肝腎，故肝腎弦緊，是即疝瘕之征也。淋閉主于少陰，故少陰弦緊，亦是淋閉之見也。

婦人有子，陰搏陽別。少陰動甚，其胎已結。滑疾不散，胎必三月。但疾不散，五月可別。陽疾爲男，陰疾爲女。女腹如箕，男腹如斧。

寸爲陽，尺爲陰，陰脉既已搏指而與陽寸之脉迥然各別，是即有子之征。心爲手少陰經，心主血，若胎已內結，則少陰之脉，勢必往來流利，厥厥如豆之動。疾即數類，滑而且數，按之不散，是其精血已聚，故有三月之胎。滑診不見，而但疾而不散，是其骨肉已成，脉無滑氣，故有五月之胎。陽疾爲男，陰疾爲女，以陽主男陰主女故耳。女胎如箕，男胎如斧，以箕圓象地象陰，斧方象天象陽故耳。陽疾陰疾，統上下表里左右而言，不拘于左右分也。

妊娠之脉，實大爲宜。沉細弦急，虛濇最忌。半

产漏下，脉宜细小。急实断绝，不祥之兆。凡有妊娠，外感风寒。缓滑流利，其脉自佳。虚濡燥急，其胎必堕。胎前下利，脉宜滑小。若见疾濡，其寿必夭。

妊娠脉宜实大，以其内实故也。沉细弦急，皆为真损胎堕之兆，最为切忌。半产漏下，脉见细小，是与病应。若胎漏既绝，脉又急实，真气已离，岂能生乎。妊娠感冒，脉宜流利，以其胎气未损故耳。虚濡燥急，是于胎气有损，故不宜见。有胎下利，脉宜滑小，而忌疾濡，以疾则气已离，以濡则血已伤故也，故以滑小为正。

临产之脉，又宜数滑。弦细短数，最属不利。产后沉小，微弱最宜。急实洪数，岐黄莫治。新产伤阴，血出不止。尺不上关，其命即丧。新产中风，热邪为殃。浮弱和缓，与病相当。小急弦濡，顷刻身亡。

临产脉乱滑数，是即胎动之应。若弦细短数，则于胎中有损，最为不利。产后胎兒已下，肚腹空虚，实数不与症应，故曰不治。新产出血不止，尺不上关，元气下脱，不死何待。至于中风脉见和缓，内气未动，故曰相当。如至小急弦濡，则内气已绝，无复生矣。

男子久病，当诊于气。脉强则生，脉弱则死。女子久病，当诊于血。脉弱则死，脉强则生。

久病则真气多损，故诊强弱以辨生死。但男子则当以气为诊，以男主于气也。女人则当以血为诊。以女主于血故也。右寸脉强，则气未损，故曰可生。左寸脉旺，则血未竭，故曰不死。

斑疹之脉，沉而且伏。火盛于表，阳脉浮数。热盛于里，阴脉实大。痘疹弦直，或沉细迟。汗后欲解，脉潑如蛇。伏坚尚可，伏弦堪嗟。

斑疹脉見沉伏，以毒本未伸泄故耳，仍須以脉数实辨其屬表屬里。痘疹最宜外出，不宜內伏，故弦直細迟犹可升托，即伏不弦，犹可內解。若至伏弦，則毒內入已深，不能外出，所以堪嗟。

癰疽未潰，脉宜洪大。及其已潰，洪大始戒。肺癰已成，寸数而实。肺痿之脉，数而無力。肺癰色白，脉宜短濇。浮大相逢，气損無失。腸癰实热，滑数可必。沉細無根，其死可測。

未潰屬实，洪大宜矣。潰后則虛，而脉犹見洪大，豈其宜乎。肺癰已成，寸实無慮，以膿在肺未除故也。肺痿則肺叶焦痿，脉数無力，亦所应見。惟肺癰几作，肺气虛損，其色应白，則脉亦当短濇，方与症应。若見浮大，知是气損血失，賊邪乘金，最非吉兆。腸癰本屬实热，必得滑数，方云無事。若見沉細，是謂無根，丧期在即。

奇經八脉，不可不察。直上直下，尺寸俱牢。中央坚实，冲脉昭昭。胸中有寒，逆气里急。疝气攻心，支滿溺失。

奇經者，不在十二正經之列，故以奇名。直上直下，弦長相似，尺寸俱牢，亦兼弦長，中央坚实，是明胸中有寒，故見逆气里急之症。如疝气攻心，正逆急也。支滿，脹也。溺失者，冲脉之邪干于腎也。

直上直下，尺寸俱浮。中央浮起，督脉可求。腰背彊痛，風痼为憂。

直上直下，則弦長矣；尺寸俱浮，中央亦浮，則六部皆浮，又兼弦長矣；故其見症皆屬風象。大抵風伤衛，故于督表見之；寒伤营，故于冲里見之。

寸口丸丸，紧細实長。男疝女瘕，任脉可詳。

寸口者，統寸关尺三部而言，非專指寸一部也。丸丸，動貌。紧細

实長，因寒实于其內而見也。男疝女瘕，即所謂苦少腹邊臍，下引陰中切痛也。

寸左右彈，陽蹻可決。或癰或癰，病苦在陽。尺左右彈，陰蹻可別。或癰或癰，病苦在陰。关左右彈，帶脉之訊。病主帶下，腹脹腰冷。

左右彈，緊脉之象也。陽蹻主陽絡，故应于寸而見浮緊而細。陰蹻主陰絡，故应于尺而見沉緊。帶脉狀如束帶，在人腰間，故应于关而見浮緊。緊主寒，故三脉皆見寒症。如陽蹻則或見为厥仆倒地身軟作声而癰，或筋緩而伸为癰，盖癰動而屬陽，陽脉主之。陰蹻則或見为語言顛倒舉止錯動而癰，或筋急而縮为癰，盖癰靜而屬陰，陰脉主之。帶則病發腰腹，而有腹脹腰冷帶下之症矣。

尺外斜上，至寸陰維。其病在里，故苦心痛。尺內斜上，至寸陽維。其病在表，故苦寒熱。

从右尺手少陽三焦，斜至寸上手厥陰心胞絡之位，是陰維脉也。从左尺足少陰腎經，斜至寸上手太陽小腸之位，是陽維脉也。二脉皆載九道圖中。斜上不由正位而上，斜向大指，名为尺外；斜向小指，名为尺內。二脉一表一里，在陰維主里，則見心痛；陽維主表，則見寒熱是也。

脉有反关，動在臂后。別由列缺，不干証候。

反关本于有生之初，非病脉也，故曰不干症候。其脉不行寸口，由列缺絡入臂后手陽明大腸之經。以其不順行于关，故曰反关。凡見关上無脉，須令病人复手以取方見。

經脉病脉，業已昭詳。將絕之形，更当度量。心絕之脉，如操帶鉤。轉豆躁疾，一日可憂。

經曰：脉来前曲后居，如操帶鉤，曰心死。前曲者，謂輕取則堅強而不柔。后居者，謂重取則牢實而不动。如持革帶之鉤，全失冲和之氣。但鉤無胃，故曰心死。轉豆者，即經所謂如循薤苡子果累然，狀其

短实坚强，真脏脉也。又曰：心絕，一日死。

肝絕之脉，循刀責責。新張弓弦，死在八日。

經曰：眞肝脉至，中外急如循刀刃。又曰：脉来急益勁，如新張弓弦，曰肝死。又曰：肝絕，八日死。

脾絕萑啄，又同屋漏。一似流水，还如杯复。

旧訣曰：雀啄連来四五啄，屋漏少刻一点落。若流水，若杯复，皆脾絕也。經曰：脾絕，四日死。

肺絕維何，如風吹毛。毛羽中膚，三日而号。

經曰：如風吹毛，曰肺死。又曰：眞肺脉至，如以毛羽中人膚。皆狀其但毛而無胃气也。又曰：肺絕，三日死。

腎絕如何，發如夺索。辟辟彈石，四日而作。

經曰：脉来如夺索，辟辟如彈石，曰腎死。又曰：腎絕，四日死。旧訣云：彈石硬来寻即散，搭指散乱如解索。正謂此也。

命脉將絕，魚翔蝦遊。至如湧泉，莫可挽留。

旧訣云：魚翔似有又似無，蝦遊靜中忽一躍。經云：渾渾革至如泉湧，綿綿其去如弦絕。皆死脉也。

卷 三

汪昂訂十二經脉歌

總按：十二經絡，皆為人身通氣活血之具。其脉周流岐別，不可不為辨論，以究病情之起端，邪氣之勝負，氣血之盈虧，則臨症索病，自有其樞，而不為其所惑矣，此經絡歌義之不容忽也。玩書有言，直行為經，旁行為絡。一似經絡之義，業已盡是。詎知人身經絡，其理推究靡旁，

有可分論而見其端者，有可合論而得其意者。其分論而見，蓋以經起中焦，常隨營氣下行而上。絡起下焦，恒附營氣上行而下。經起中焦，則經氣之上升，實有过于其絡。絡起下焦，則絡氣之下降，實有越于其經。故經多以氣主，而絡多以血主也。經主于氣，故凡外邪之入，多于經受，而絡常处于后；絡主于血，故凡經邪之滿，轉溢于絡，而絡始得以受。是以經常處實，絡常處虛。絡得由經而實，而絡亦不得以虛名也。經因受邪最早，故症多以寒見，而脈亦寸浮而緊；絡因受邪稍緩，故症多因熱成，而脈常見尺數而濡。經則隨行上下，邪本易受，而開發最易；絡則邪伏隱僻，邪即難入，而升散維艱。即經有言絡處經外，邪入先自絡始；然既由絡入經，而經流連不散，則邪又溢于絡，而見纏綿不已，故經與絡又各自病。是其各別之勢，有不相混如此。以經絡通同而論，則經與絡，虽各本于臟氣之受，然究不越人身大氣以為鼓運，故能流行不悖。設非大氣磅礴，則彼盛此衰，生氣有阻，其何以為長養元氣之自乎。此其會通之妙，又有不容或忽如此。是以初病多責于經，久病多責于絡。久病而再流連不解，則又多責于經之奇。以故仲景著為傷寒論法，多以經傳立解。孫思邈著為千金等書，多以絡病久病立說。即今姑蘇叶天士，祖孫思邈，作為臨症指南集，亦以久病活絡為要，皆與經絡不悖。第其經穴眾多，其中錯綜分行，自非纂誦，難以記憶。因閱汪昂本草備要所訂古本歌訣，頗有便世，用是附載以為采擇，非惟初學得此，可以誦習，即老醫得此，亦可以為臨症之一助也。

手太陰肺經 手太陰肺(脈)中焦起，下絡大腸(肺與大腸相表裏)胃口行(胃之上脘即賁門)。上膈屬肺从肺系(即喉管)，橫从腋下臑內筋(臑下對腋處名臑，音柔)。前于心與心胞脈(行少陰心主之前)，下肘循臂骨上廉(臑盡處為肘，肘以下為臂)，遂入寸口上魚際(關前動脈為寸口，大指後肉隆起處名為魚，魚際，其間穴名)，大指內側爪甲根(少商穴止)。支絡還从腕後出(臂骨盡處為腕)，接次指交陽明經(大腸)。此經

多气而少血，是动则为喘满咳（肺主气）。膨膨肺脹缺盆痛（膈下横骨陷中名缺盆，陽明胃經穴），兩手交替（音茂）为臂厥。肺所生病欬上气，喘渴（金不生水）煩心（心脉上肺）胸滿結（脉布胸中）。臑臂之内前廉痛，为厥或为掌中热（脉行少陰心主之前，掌心劳宮穴，屬心包）。肩背痛是气（盛）有余（絡脉交于手，上肩背），小便数（而）欠（便頻而短）或汗出（肺主皮毛）。气虛亦痛（肩背寒痛）溺色变（母病及子），少气不足以报息（肺虛）。

手陽明大腸經 手陽明經大腸脉，次指內側起商陽（本經穴名）。循指上廉出合谷（俗名虎口穴），兩骨（兩指岐骨間）兩筋中間行（手背外側，兩筋陷中，陽谿穴）。循臂入肘（外廉）行臑外（廉），肩隅（音隅，肩端兩骨）前廉柱骨傍（上出膀胱經之天柱骨，会于督脉之大椎）。会此（六陽經皆会于大椎。故經文云上出于柱骨之会上）下入缺盆內（膈下横骨陷中），絡肺下膈屬大腸（相为表里）。支从缺盆上入頸，斜貫兩頰下齿当。挟口人中（鼻下溝瀆）交左右，上挟鼻孔尽迎香（本經穴終，交足陽明）。此經血盛气亦盛，是动齿痛頸亦腫。是主津液病所生（大腸主津），目黃（大腸內热）口干（無津）𩑦𩑦动（𩑦，音求，鼻水。𩑦，鼻血），喉痺（金燥）痛在肩前臑，大指次指痛不用（不隨人用，皆經脉所过）。

足陽明胃經 足陽明胃（脉）鼻頰起（山根），下循鼻外入上齿。环唇俠口交承漿（下唇陷中），頤后大迎頰車

里(臄下为額,額下为頤,耳下为頰車。大迎,額下穴名)。耳前髮际至額顙,支循喉嚨缺盆入。下膈屬胃絡脾宮(相为表里),直者下乳俠臍中。支(者)起胃口循腹里,下行直合气街逢(即气冲)。遂由髀关(抵伏兔)下膝膑(挟膝兩筋为膑,一曰膝盖),循脛(外廉下)足跗(足面)中指通。支从中指入大指,属兌之属經尽矣(交足太陰)。此經多气复多血,振寒呻欠(呻吟呵欠)而顏黑。病至惡見火与人(血气盛而热甚),忌聞木声心惕惕(陽明土惡木也)。閉戶塞牖欲独处,甚則登高(而歌)棄衣(而)走。賁(奔)响腹脹(脉循腹里,水火相激而作声)为肝厥(足脛为肝),狂瘡溫淫及汗出(陽明法多汗),𩑦𩑦口喎并唇唇(音軫,唇瘍。脉挟口环唇),頸腫喉痺(循頤循喉)腹水腫(土不制水)。膺乳(膺窗、乳中、乳根,皆本經乳間穴)膝膑股伏兔(膝上六寸肉起处),肝外足跗上皆痛。气盛热在身以前(陽明行身之前),有余消谷(善飢)溺黃甚。不足身以前皆寒,胃中寒而腹脹壅。

足太阴脾經 太陰脾(脉)起足大指,循指內側白肉际。过核骨后(孤拐骨。張景岳曰:非也,即大指后圓骨)內踝前(脛旁曰踝),上臄(音善,足肚也。一作踰,音短,足跟也。然經中二字通用)循脛膝股里。股內兼廉入腹中,屬脾絡胃(相为表里)上膈通。俠咽連舌(本,舌根也)散舌下,支者从胃(上膈)注心宮。此經血少而气旺,是动即病舌本强(上声)。食則嘔出胃脘痛,心中善噫(即噯)而腹脹。得后与气

(大便噎气)快然衰(病衰),脾病身重(脾主肌内)不能(动)搖。
癥泄(癥积泄瀉)水閉及黃疸(脾湿),煩心心痛(即胃脘痛)食
难消(食不下)。强立股膝内多腫(脾主四肢),不能臥因胃
不和。

手少阴心經 手少陰心(脉)起心經,下膈直絡小
腸承(相为表里)。支者挾咽系目系,直者(从)心系上肺
膈。下腋循臑后廉出,太陰(脉)心主(心包)之后行。(行
二脉之后)。下肘循臂(内后廉)抵掌后,銳骨之端(掌后尖骨)
小指停(少冲穴,交手太陽)。此經少血而多气,是动咽干
(少陰火,脉挾咽)心痛应。目黃脅痛(系目出胁)渴欲飲,臂
臑内(后廉)痛掌热蒸。

手太阳小腸經 手太陽經小腸脉,小指之端起少
澤(本經穴)。循手(外側)上腕(臂骨尽处为腕)出踝中(掌側腕下
銳骨为踝),上臂骨(下廉)出肘内側。兩筋之間臑(外)后
廉,出肩解(脊傍为膂,膂上兩角为肩解)而繞肩胛(肩下成片
骨)。交肩之上入缺盆(膂下横骨陷中),直絡心中循嗌咽。
下膈抵胃屬小腸(小腸与心为表里)。支从缺盆上頸頰,至
目銳眦入耳中(至本經听宫穴)。支者別頰复上頤(音拙,目
下),抵鼻至于目内眦(内角),絡頰交足太陽接。嗌痛頰
腫(循咽循頰)头难回(不可以頤),肩似拔兮臑似折(出肩循
臑),耳聾目黃腫頰間(入耳至眦上頰)。是所生病为主液
(小腸主液),頸頰肩臑肘臂(外廉)痛。此經少气而多血。

足太陽膀胱經 足太陽經膀胱脉，目內眥上額交巔。支者从巔入耳（上）角，直者从巔絡腦間。还出下項循肩膊（肩后之下为膊），挾脊（去脊各一寸五分，行十二俞等穴）抵腰循脊旋（脊傍为脊）。絡胃正屬膀胱腑（相为表里），一支貫腎入臑傳（从腰中下挾脊，行上中次下髎等穴，入臑委中穴，膝后曲处为臑）。一支从膊別貫胛（胛肉为胛），挾脊（去脊各三寸行附分魄戶膏肓等穴）循髀（髀樞，股外为髀）合臑行（与前入臑者合）。貫臑（足肚）出踝（經傍曰踝）循京骨（本經穴，足外側赤白肉际），小指外側至陰（穴）全（交足少陰）。此經少气而多血，头痛脊痛腰如折。目似脫兮項似拔，臑如結兮臑如裂。痔（脉入肛）瘡（太陽瘡）狂癲疾并生（癲狂篇亦有刺太陽經者），黥衄（太陽經气不能循經下行，上冲于腦而为黥衄）目黃而淚出。顙項背腰尻臑臑（尻，苦高切）病若动时皆痛徹。以上病皆經脉所过。

足少陰腎經 足腎經脉屬少陰，斜从小指趣足心（湧泉穴）。出于然骨（一作谷，足內踝骨陷中）循內踝，入跟（足后跟）上臑臑內（廉）寻。上股（內）后廉直貫脊（会于督脉長强穴），屬腎下絡膀胱深（相为表里）。直者从腎貫肝膈，入肺挾舌（本）循喉嚨。支者从肺絡心上，注于胸（膻中）交手厥陰（心包經）。此經多气而少血，是动病飢不欲食（腹內飢而不嗜食），咳唾有血（脉入肺故咳。腎主唾，腎損故見血）喝喝喘（腎气上奔），目眈（瞳子屬腎）心悬（脉絡心，水不制火）坐起

輒(坐而欲起,陰虛不寧),善恐(心惕傷)如人將捕之(腎志恐),咽腫舌干兼口熱(少陰火),上氣(腎水溢而為腫)心痛或心煩(脈絡心),黃疸(腎水乘脾,或為女勞疸)腸澼(腎移熱于脾胃大腸,或痢或便血)及痿(骨痿)厥(下不足則上厥),脊股后廉之內痛,嗜臥(少陰病,但欲寐)足下熱痛切。

手厥陰心胞經 手厥陰經心主標,心包下膈絡三焦(心包與三焦為表里)。起自胸中(膻中)支(者)出脅,下腋三寸循臑(內)迢。太陰(肺)少陰(心)中間走,入肘下臂兩筋超(掌後兩筋橫紋陷中),行掌心(勞宮穴)从中指出(中沖穴),支從小指次指交(小指內之次指,交三焦經)。是經少氣原多血。是動則病手心熱(肘臂掣急,腋下腫,甚則支滿在胸脇,心中憺憺時大動,面赤目黃笑不歇),是主脈所生病者(心主脈),掌熱心煩心痛掣(皆經脈所過)。

手少陽三焦經 手少陽經三焦脈,起手小指次指間(無名指關沖穴)。循腕(表手背)出臂(外)之兩骨(天井穴),貫肘循臑外上肩。交出足少陽(胆)之後,入缺盆佈膻中傳(兩乳中間)。散絡心包而下膈,循屬三焦表里聯(三焦與心包為表里)。支從膻中缺盆出,上項出耳上角巔。以屈下頰而至頤,支從耳後入耳(中)緣。出走耳前(過胆經客主人穴)交兩頰,至目銳眦(外角)胆經連(交足少陽)。是經少血還多氣,耳聾咽腫及喉痺(少陽相火)。氣所生病(氣分三焦心胞皆主相火)汗出多(火蒸為汗),頰腫痛及目銳

皆，耳后肩髃肘臂外，皆痛廢及小次指（小指次指不用）。

足少阳胆經 足少陽脉胆之經，起于兩目銳眦边。上抵头角下耳后，循頸行手少陽前（三焦）。至肩却出少陽后，入缺盆中支者分。耳后入耳（中）耳前走，支別銳眦下大迎（胃經穴，在頰前一寸三分动脉陷中）。合手少陽抵于頤（目下），下加頰車下頸連。复合缺盆下胸（膺）膈，絡肝屬胆表里滎（相为表里）。循肱里向气街出（俠臍四寸动脉），繞毛际入髀厭橫（橫入髀厭，即髀樞）。直者从缺盆下腋，循胸季肋过章門（肋骨下为季肋，即肝經章門穴）。下合髀厭（即髀樞）髀陽外（循髀外行太陽陽明之間），出膝外廉外輔（骨，即膝下兩傍高骨）緣。下抵絕骨出外踝（外踝以上为絕骨，少陽行身側，故每言外），循跗（足面）入小次指間。支者別跗入大指，循指歧骨出其端（足大指本节后为歧骨交肝經）。此經多气而少血，是动口苦（胆汁上溢）善太息（木气不舒）。心胁疼痛轉側难，足热（足外反热）面塵体無澤（木郁不能生榮）。头痛額痛銳眦痛，缺盆腫痛亦腫脇。馬刀俠癭頸腋生（少陽瘡瘍堅而不潰），汗出（少陽相火）振寒多瘡疾（少陽居半表半里，故瘡發寒熱，多屬少陽）。胸脇髀膝（外）脛絕骨，外踝皆痛及諸节（皆經脉所过）。

足厥阴肝經 足厥陰肝脉所終，大指之端毛际叢（起大敦穴）。循足跗上（廉）上內踝（中封穴），出太陰后（脾脉之后）入臑中（內廉）。循股（陰）入毛（中）繞陰器，上抵小腹

俠胃通。屬肝絡胆（相為表里）上貫膈，布于肋肋循喉嚨（之后）。上入頄顙（頄顙，本篇后又云絡舌本）連目系，出額會督頂巔逢（與督脉會于巔百會穴）。支者復从目系出，下行頰里交環唇。支者从肝別貫膈，上注于肺乃交宮（交于肺經）。是經血多而氣少，腰痛俯仰難為工（不可俯仰）。婦少腹痛男瘕疝（脉抵小腹環陰器），噎乾（脉絡喉嚨）脫色面塵蒙（木郁）。胸滿嘔逆及殭泄（木尅土），狐疝遺尿（肝虛）或閉瘡（肝火）。

汪昂奇經脉歌

續按：奇經八脉，前人論之詳矣。考諸時珍有言，八脉陽維起于諸陽之會，由外踝而上行于衛分；陰維起于諸陰之交，由內踝而上行于營分；所以為一身之綱維也。陽蹻起于跟中，由外踝而上行于身之左右；陰蹻起于跟中，循內踝而上行于身之左右；所以使机关之蹻捷也。督脉起于會陰，循背而行于身之后，為陽脉之總督，故曰陽脉之海；任脉起于會陰，循腹而行于身之前，為陰脉之承任，故曰陰脉之海。冲脉起于會陰，夾臍而行，直冲于上，為諸脉之冲要，故曰十二經之海。帶脉則橫圍于腰，狀如束帶，所以總約諸脉者也。是故陽維主一身之表，陰維主一身之里，以乾坤言也。陽蹻主一身左右之陽，陰蹻主一身左右之陰，以東西言也。督主身後之陽，任冲主身前之陰，以南北言也。帶脉橫束諸脉，以六合言也。又考張潔古有云：蹻者，捷疾也。二脉起于足，使人蹻捷也。陽蹻在肌肉之上，陽脉所行，通貫六腑，主持諸表，故名為陽蹻之絡。陰蹻在肌肉之下，陰脉所行，貫通五臟，主持諸里，故名為陰蹻之絡。觀諸所論八脉，雖在十二經絡之外，因別其名為奇，然亦可為正經正絡之輔。蓋正經猶于地道之溝渠，奇經猶于溝渠外之湖澤。正經之溝渠不涸，則奇經之湖澤不致甚竭；正經之溝水既滿，則奇經之湖澤必溉。所以昔人有云：臟氣安和，經脉調暢，八脉之形無從而見，即經絡受

邪不致滿溢，與奇經無預。若經絡之邪熱既滿，勢必溢於奇經。如天雨降下，溝渠滿溢，滂霈妄行，流于湖澤之意，正自相符。且諸經皆為臟腑所配，此則自為起止，不與正經之例相同，故奇經又為十二經之約束。是以傷寒之邪，有從陽維而始傳次三陽，有從陰維而始傳次三陰。并臟氣內結，邪氣外溢，竟從奇經先受。然此由邪入內，而不予奇是留，非若十二經熱滿之必見有溢奇之日也。時珍云：醫而知乎八脈，則十二經十五絡之大旨得；仙而知乎八脈，則龍虎升降玄牝幽微之竅妙得。又曰：醫不知此，罔探病機；仙不知此，難安爐鼎。旨哉斯言，錄此以為醫之一助。

任脈起于中極底（臍下四寸，穴名中極。任脈起于其下二陰之交会陰之穴。任由會陰而行腹，督由會陰而行背），以上毛際循腹里（行中極穴），上于關元（臍下三寸穴名）至咽喉，上頤循面入目是（絡于承泣）。冲（脈）起氣街并少陰（腎脈），俠臍上行胸中至（任脈當臍中而上，冲脈俠臍旁而上。以上并出素問骨空論）。冲為五臟六腑海（冲為血海），五臟六腑所稟氣。上滲諸陽（經）灌諸精（上出頰頰），從下冲上取茲義（故名冲）。亦有并腎下行者，注少陰絡氣街出。陰股內廉入臍中（膝后曲處），伏行筋骨內踝際。下滲三陰（肝脾腎）灌諸絡，以溫肌肉至跗指（循足面下湧泉入足大指。此段出靈樞經順肥瘦篇）。督（脈）起少腹骨中央，入系廷孔（女人陰廷溺孔之端，即窵漏穴）絡陰器。合篡（二陰之交名篡）至后別繞腎，與臣陽絡（太陽中絡）少陰比（與膀胱、腎二脈相合）。上股（內后廉）貫脊屬腎行，上同太陽起（目）內眥。上額交巔絡腦間，下項循肩（膊內）仍俠脊。抵腰絡腎（此腎脈并太陽

而行者)循男莖(男子陰莖)，下篡亦与女子类。又从少腹貫臍中(央)，貫心入喉頤及唇(环唇)。上系目下中央际，此为并任(此督脉并任脉而行者)亦同冲(脉)。大抵三脉同一本(冲任督三脉皆起于会陰之下，一原而三歧，異名而同体)，灵素言之每錯綜(灵樞五音五味篇；冲脉、任脉，皆起于胸中，上循背里。是又言冲任行背。故經亦有謂冲脉为督脉者。古圖經有以任脉循背者謂之督。自少腹直上者謂之任，亦謂之督。今人大率以行身背者为督，行身前者为任，从中起者为冲。然考任督二經所行穴道，一在身前，一在身后；而冲脉居中，則無穴道。似当以此說为正)。督病少腹(上)冲心痛，不得前后(二便不通)冲疝攻(此督脉为病同于冲脉者)。其在女子为不孕(冲为血海，任主胞絡)，噎干(脉循咽喉)遺尿及痔瘡(絡陰器，合篡間。此督脉为病同于冲任者)。任病男疝(內結七疝)女瘕帶(帶下瘕聚即婦人之疝)，冲病里急气逆冲(血不足故急，气有余故逆。此段出素問骨空論。督者，督領諸經之脉也。冲者，其气上冲也。任者，女子得之以任养也)。蹻(陰蹻脉)乃少陰(腎)之別脉，起然骨后(足內踝大骨之下，照海穴)至內踝。直上陰股入陰間，上循胸入缺盆过。出人迎前(胃經，頸旁动脉)入頰(顴)眦(目內眦，睛明穴)，合于太陽陽蹻和(陽蹻脉始于膀胱經之申脉穴，足外踝下陷中。此段出灵樞脉度篇)，此皆灵素說奇經，帶及二維未說破。

新增脈要簡易便知

浮 如水漂木。主表实，亦主里实虛。

沉 重按乃得在筋骨間。主里实，亦主里虛。

数 一息六至。主实热，亦主虛寒。

迟 一息三至。主虛寒，亦主实热。

长 指下迢迢。上至魚际，下至尺澤。主气治，亦主陽盛陰虛。

短 兩头縮縮。寸不通魚际，尺不通尺澤。主气損，亦主中壅。

大 应指滿溢。長而無力。主邪盛，亦主正虛。

小 三部皆小。指下显然。主气虛，亦主內实。

洪 来盛去悠。既大且数。主热極，亦主內虛。

微 按之模糊。若有若無，浮中沉皆是。主陰陽气絕，亦主邪实。

实 举指逼逼。举按皆强。主热实，亦主寒实。

虛 豁然浮大。浮見。主气血空虛。

紧 勁急彈手。彈如轉索。主寒閉，亦主表虛。

緩 来去和緩。主無病，亦主实热虛寒。

濡 如絮浮水。浮見。主气衰，亦主外湿。

弱 小弱分明。沉見。主气虛，亦分陰陽胃气。

芤 按之減小。浮沉皆有，中取減小。主血虛。

弦 端直而長。浮沉皆見。主木盛土衰，亦看兼脉。

滑 往来流利。数見。主痰飲，亦主气虛不統。

澹 往来艰澹。迟見。主血虛，亦主寒湿热閉。

动 兩关滑数如珠。主陰陽相搏。

伏 着骨始得。較沉更甚。主邪閉，亦分痰火寒氣。

促 数时一止。主陽邪內陷。

結 迟时一止。主氣血漸衰，亦主邪結。

革 浮取强直，按之中空。主精血虛損。

牢 沉取强直搏指。沉伏之間。主寒實。

疾 一息七八至。主陽亢，亦主陽浮。

細 細如蛛絲。主氣虛，亦主熱結里虛。

代 止歇有时。主氣絕，亦主經隧有阻。

散 来去不明。主氣散。

督 輕取弦長而浮。六脉皆見。主風傷身後總攝之陽，故脊强不能俯仰。

冲 按之弦長堅實。六脉皆是。主寒傷身前冲要之陰，故氣逆里急。

任 緊細而長。六脉形如豆粒。主寒傷身前承任之陰，故少腹切痛。

阳維 右尺內斜至寸而浮。主邪傷一身之表，故寒熱不能自持。

阴維 左尺外斜至寸而沉。主邪傷一身之里，故心痛失志。

阳蹻 兩寸左右彈浮緊細。主邪傷左右之陽，故腰背苦痛。

阴蹻 兩尺左右彈沉緊細。主邪傷左右之陰，故少腹切痛。

帶脈 兩关左右彈滑而緊。主邪傷中腰帶束之處，故腰腹痛。

有力 久按根底不絕。非堅勁搏指。主病無害，亦防氣逆。

有神 光澤潤滑。穩厚肉里，不離中部。主病治，亦防痰畜。

胃氣 脉緩和勻。意思悠悠。主病愈，亦忌谷食減少，寸口脉平。



0051844